

18.02.2025

ADLI OLGULARDA HEMŞİRELİK



sibel cezayir çubukçu

1.ADLİ OLGULAR

1.1 Adli Acil Servis Olguları

2.ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARLARI

2.1 Çocuk İstismarları

2.1.1 Fiziksel İstismar

2.1.2 Duygusal İstismar

2.1.3 Cinsel İstismar

2.1.4 Ekonomik İstismar

2.2 Çocuk İhmalleri

2.2.1 Çocuk İhmali Belirtileri

2.2.2 Çocuk İhmali Risk Faktörleri

2.2.3 INSPIRE Stratejileri

2.2.4 Kocaeli Üniversitesi HASTanesi Adli Vaka Verileri

2.2.5 Çalışmalar

3.ACİL BİRİMDE ADLİ OLGUYA YAKLAŞIM

3.1 Adli Değerlendirmenin Ögeleri

3.2 Vaka Örnekleri

3.3 Adli Olgularda Hemşirelik Bakımı

3.4 İstismar Olayını Bildirebileceğiniz Birimler

4.GÖRSELLER

5.KAYNAKÇA



ADLİ OLGU

Bir kişinin **sağlığının bozulmasında başka bir kişi ya da kurumsal bir yapının rolünün** bulunduğu, bunun **iddia edildiği** veya **sağlık personelinin böyle bir olasılıktan şüphelendiği** durumlar; içinde suç unsuru barındıran ve yargılama sürecine konu olması öngörülen tüm olgular adli olgu kapsamında değerlendirilmektedir (Saka, Çelik, & Ata, 2024).

Her türlü ateşli
silah ve patlayıcı
madde ile olan
yaralanmalar

- Trafik
kazaları,
- düşmeler,
- darp olguları
- iş kazaları

İntoksikasyonlar
(ilaç, boğucu gazlar)

İşkence iddiaları

ADLİ ACİL SERVİS OLGULARI (TÜM YAŞ GRUPLARI)

(Saka, Çelik, & Ata, 2024)

Her türlü

- kesici,
- kesici-batıcı
(kesici-delici),
- batıcı (delici),
- kesici-ezici
- ezici alet
yaralanmaları,

Yanıklar
(alev, kızgın cisim,
yakıcı-aşındırıcı
madde)

Elektrik
ve yıldırım
çarpmaları

Her türlü intihar girişimleri,

İşkence iddiaları

Mekanik asfiksi olguları

- Tıkama, tıkanma,
- Ası, elle veya iple boğulma,
- Karın - göğüs tazyiki,
- Diri gömülme,
- Suda boğulma

ADLİ ACİL SERVİS OLGULARI (TÜM YAŞ GRUPLARI)

(Saka, Çelik, & Ata, 2024)

Sindirim kanalına oral veya anal yoldan yabancı madde girmesi

Tüm şüpheli ölümler
(cinayet, intihar, kaza orijinli olduğundan kuşku edilen)

İhmal ve istismarları olguları

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARLARI



Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı ve en uygun olarak kabul edilen tanımlamaya göre çocuk ihmal ve istismarı ;

Bir sorumluluk, güven ya da güç ilişkisi bağlamında çocuğun

- Sağlığına,
- Yaşamına,
- Gelişimine,
- Özsaygısına,
- Onuruna

fiilen ya da potansiyel zarar verebilen **fiziksel veya emosyonel** kötü davranışlar, cinsel istismar, ihmal ya da ihmalkâr tutumlar, ticari çıkar ve her türlü sömürü için çocuğun kullanılmasını içeren davranışlar (DSÖ, 2024).

FİZİKSEL İSTİSMAR

Çocuk veya gencin sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyecek derecede fiziksel olarak hasar verilmesi, yaralanması veya yaralanma riski bulundurulmasıdır (Pelendecioğlu ve Bulut, 2016)

Çocuğun kaza dışı ve önlenabilir tüm yaralanmalarını kapsamakta ve bu yaralanmalar genellikle ebeveyn ya da bakıcı kontrolünü yitirdiğinde veya çocuğa ceza uygulamak istediğinde ortaya çıkmaktadır.



UNICEF 2024 - KÜRESEL VERİLER (5 Yaş Altı)



400 MİLYON ÇOCUK

Ev ortamında psikolojik saldırı
veya fiziksel cezaya maruz kalıyor



330 MİLYON ÇOCUK

Ev ortamında fiziksel olarak
cecalandırılıyor.

UNICEF TÜRKİYE 2010 - 7-18 YAŞ GRUBU



**Cinsel
istismar**



**Fiziksel
istismar**

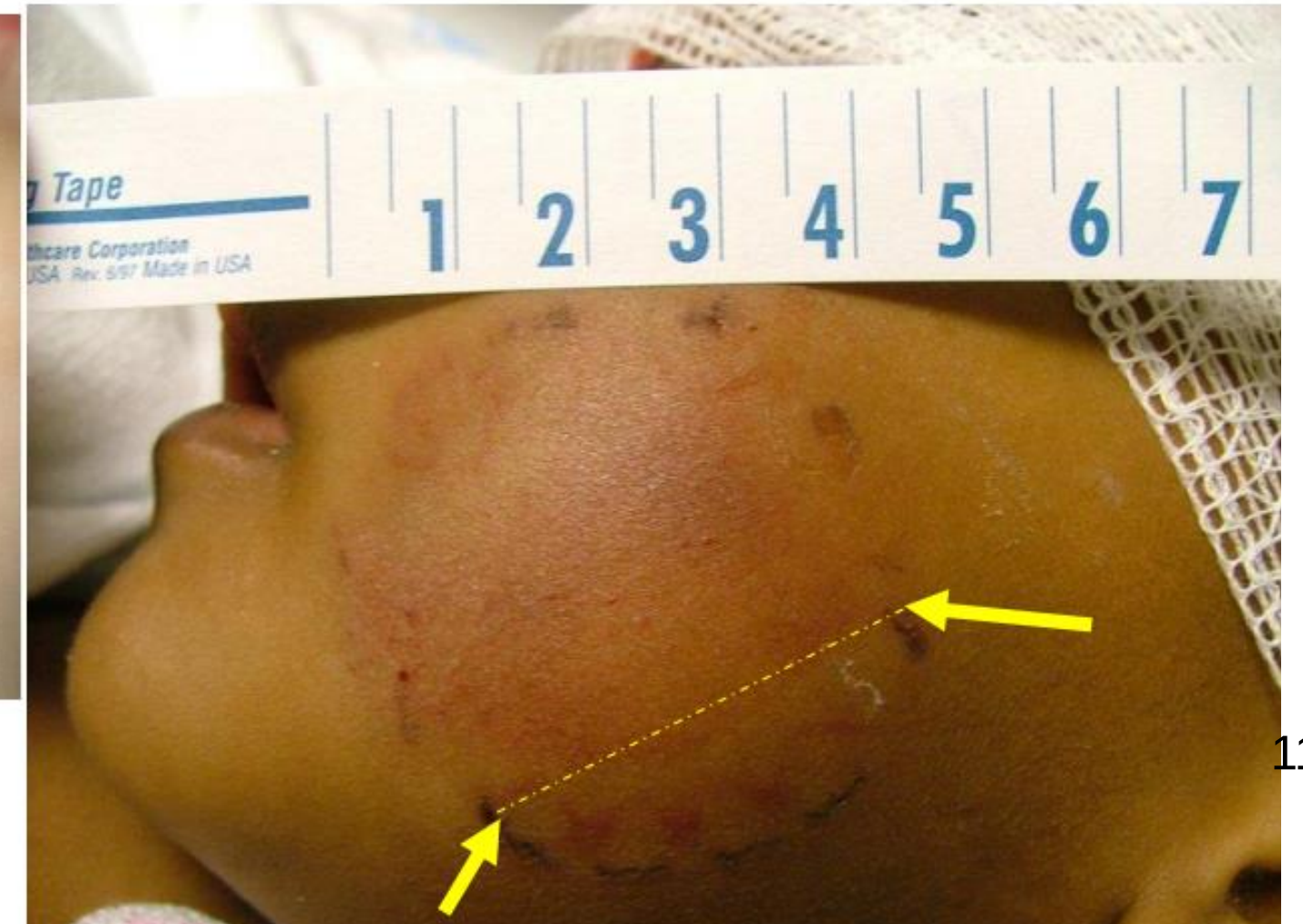
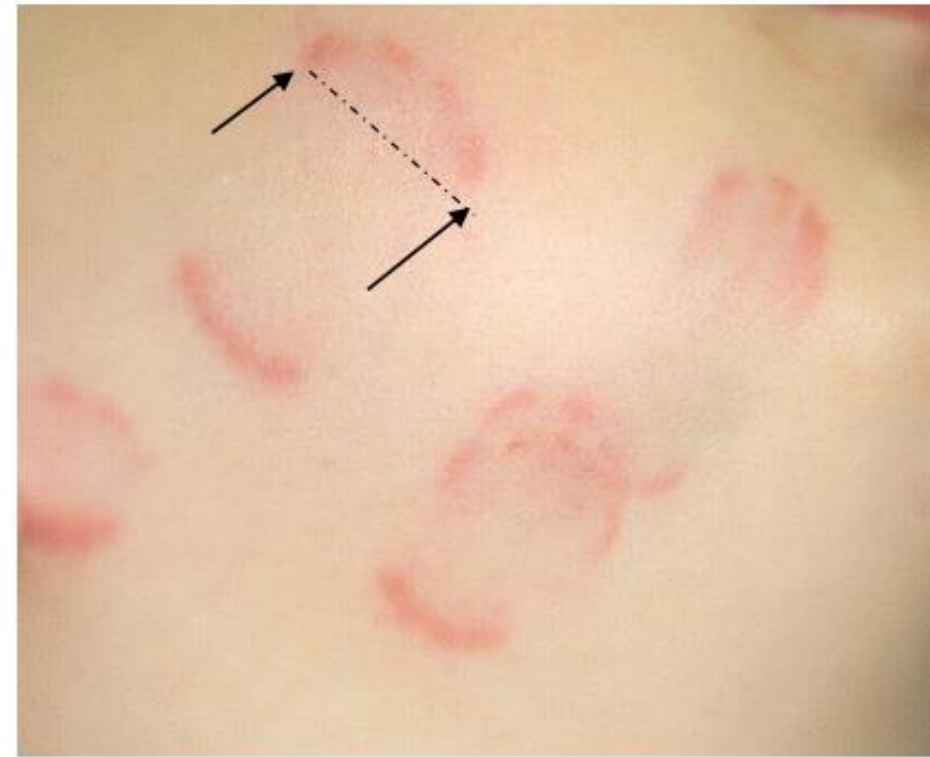


**Duygusal
istismar**





- Görseller Ege Üniversitesi'nden alınmıştır.



FİZİKSEL BELİRTİLER

- Açıklanamayan darbe, yara izleri
- Ağız ve çevresinde, yüzde, bacaklarda, kalça ve sırt bölgesinde (simetrik) morluklar,
- Kablo, giysi kemeri gibi acı vermek için kullanılan araçların izleri,
- Özellikle ayak altında, avuç içerisinde, baldırlarda ya da sırtta sigara vb. yanıkları,
- Sarsılmış bebek sendromu

(İncirkuş ve ark., 2025)

DAVRANIŞSAL BELİRTİLER

- Erişkinlerle etkileşime girmekten kaçınma,
Kendine zarar verici tutumlar,
- Fazla saldırgan veya çekimser tutum,
- Ağrı yakınmaları veya rahatsız olduğunu ifade etme,
- Vücudu korumak için iklim koşullarına göre uyumsuz olan giysiler,
- Çocukların farklı ağlama durumlarına karşı dikkatli ve anlayışlı olma,

DUYGUSAL BELİRTİLER

- Anne-babadan korkma,
- Eve gitmekten korkma,
- Yakın ilişki kuramama,
- Duygusal yoğunluğu az, çatışmalı, öfkeli ilişkiler,
- Karşı çıkma bozukluğu,

DUYGUSAL İSTİSMAR

Çocuğun bakımına ve duygusal bütünlüğüne zarar veren her türlü eylem olarak tanımlanabilmektedir. Bir çocuğun hareketlerini kısıtlamayı, aşağılamayı, alay etmeyi, tehdit ve yıldırma, ayrımcılığı, reddetmeyi ve diğer fiziksel olmayan düşmanca muamele biçimlerini kapsamaktadır (İncirkuş ve ark., 2025).



DSÔ verilerine göre, 2-4 yař aralıęındaki her dört çocuktan
üçü fiziksel ceza ve/veya duygusal řiddete maruz kalmaktadır.



3/4

Yaklařık 300 MİLYON ÇOCUK

bakıcıları veya ebeveynleri tarafından düzenli
olarak řiddet görüyor.

FİZİKSEL BELİRTİLER

- Organik temelli olmayan büyüme geriliği,
- Psikosomatik şikayetler,
- Beslenme sorunları,
- Konuşma veya diğer iletişim problemleri,
- Uyku bozuklukları,
- Çocuğun mevcut astım veya alerji gibi rahatsızlıklarının şiddetlenmesi
- Madde bağımlılığı,

DUYGUSAL BELİRTİLER

- Alışılmadık korkular,
- Güçsüzlük duygusu,



DAVRANIŞSAL BELİRTİLER

- Yalan söyleme,
- Oyuna isteksizlik, oyun kurmada güçlük,
- Antisosyal ve yıkıcı davranışlar,
- Suça eğilim,
- Saldırganlık veya pasiflik gibi aşırı davranışlar,
- Uyum sağlamada bozukluk, intihar girişimi, kendisine zarar verici davranışlar,

CİNSEL İSTİSMAR

Rıza dışı tamamlanmış veya teşebbüs edilmiş cinsel ilişkiyi, temas içermeyen cinsel nitelikteki eylemleri (röntgencilik veya cinsel taciz gibi), rıza gösteremeyen veya reddedemeyen birine karşı işlenen cinsel ticaret eylemlerini ve çevrimiçi sömürüyü içeren istismar türüdür.



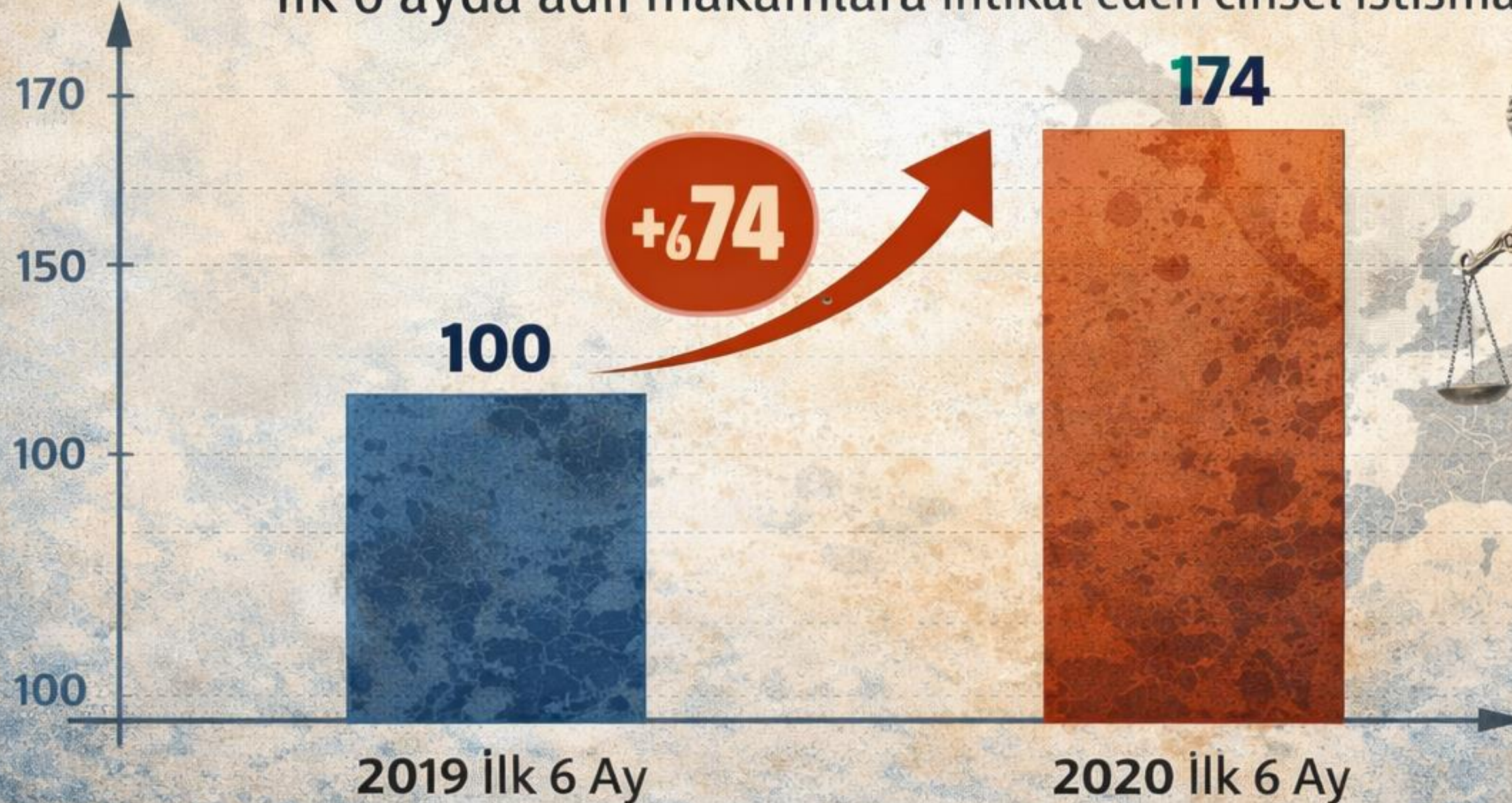
(İncirkuş ve ark., 2025)

University of Münster, Hukuk Fakóltesi Arařtırması
Türkiye'nin de alarlarında bulunduđu 51 Avrupa ülkesinde

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARI

%74 ORANINDA ARTTI

İlk 6 ayda adli makamlara intikal eden cinsel istismar suçları



FİZİKSEL BELİRTİLER

- Genital travmayı gösteren akut bulgular,
- Cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
- Yürüme ve oturmada zorluk
- Ağızda, vajinada veya anüste semen bulunması,
- Anal veya genital bölgede ağrı, irritasyon, inflamasyon,
- Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu,
- Erken dönemde gebe kalma,

(İncirkuş ve ark., 2025)

DAVRANIŞSAL BELİRTİLER

- Histeri, duygularını kontrol altına alamama,
- Okulda karşılaşılan beklenmedik güçlükler,
- Akademik başarıda düşme,
- Evden/okuldan kaçma,
- Sosyal izolasyon,
- Akranlarla ilişkide zorluk yaşama ve ilişki kurmaktan çekinme,
- Ani ve aşırı derecede kilo değişimi,
- Cinsel konularla aşırı ilgilenme,

DUYGUSAL BELİRTİLER

- Suçluluk ve utanç duygusu,
- Anksiyete,
- İntihar fikirleri,
- Depresyon,
- Post travmatik stres bozukluğu,
- Madde kötüye kullanımı,
- Kâbus ve uyku bozuklukları,
- Öğrenme güçlüğü,
- Yeme bozuklukları,
- Fobiler, dokunmaya hassasiyet,
- Benlik saygısında bozulma,

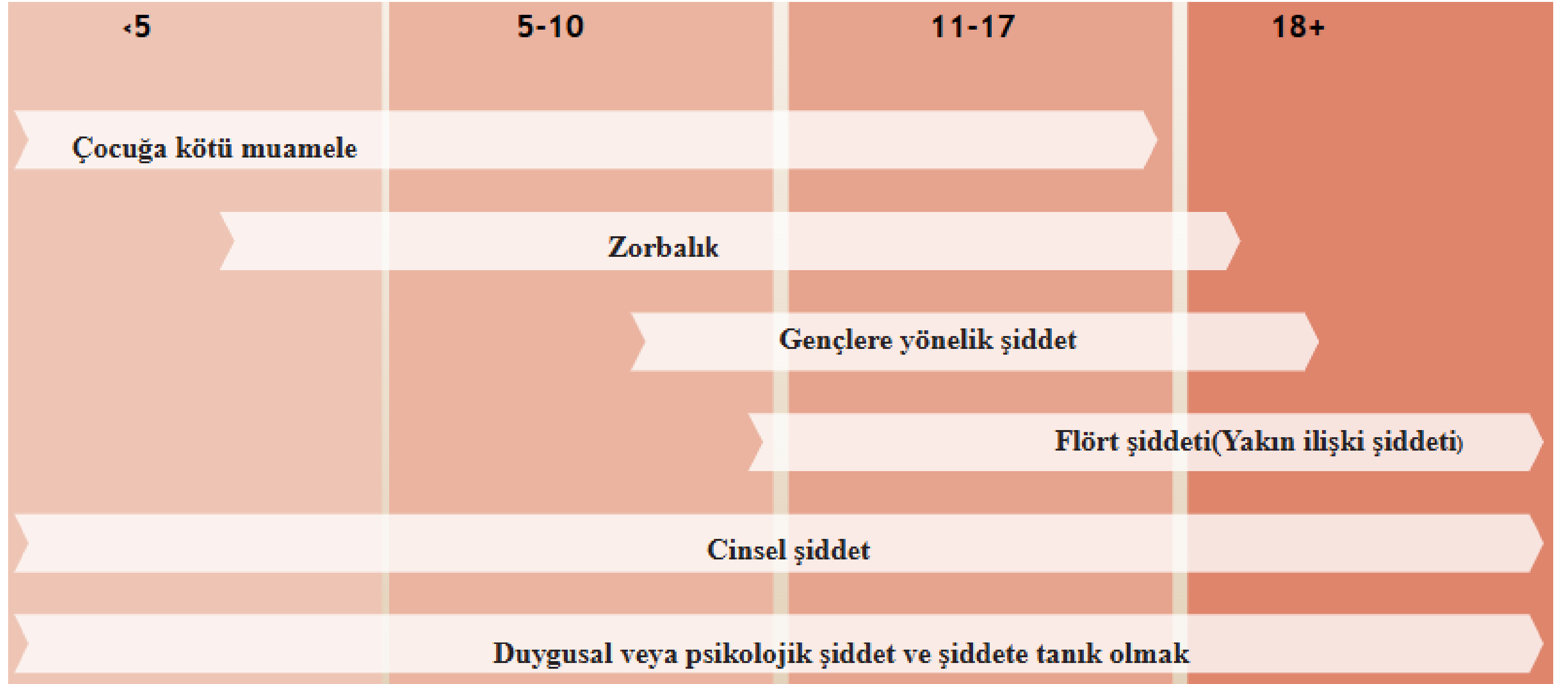
(İncirkuş ve ark., 2023)

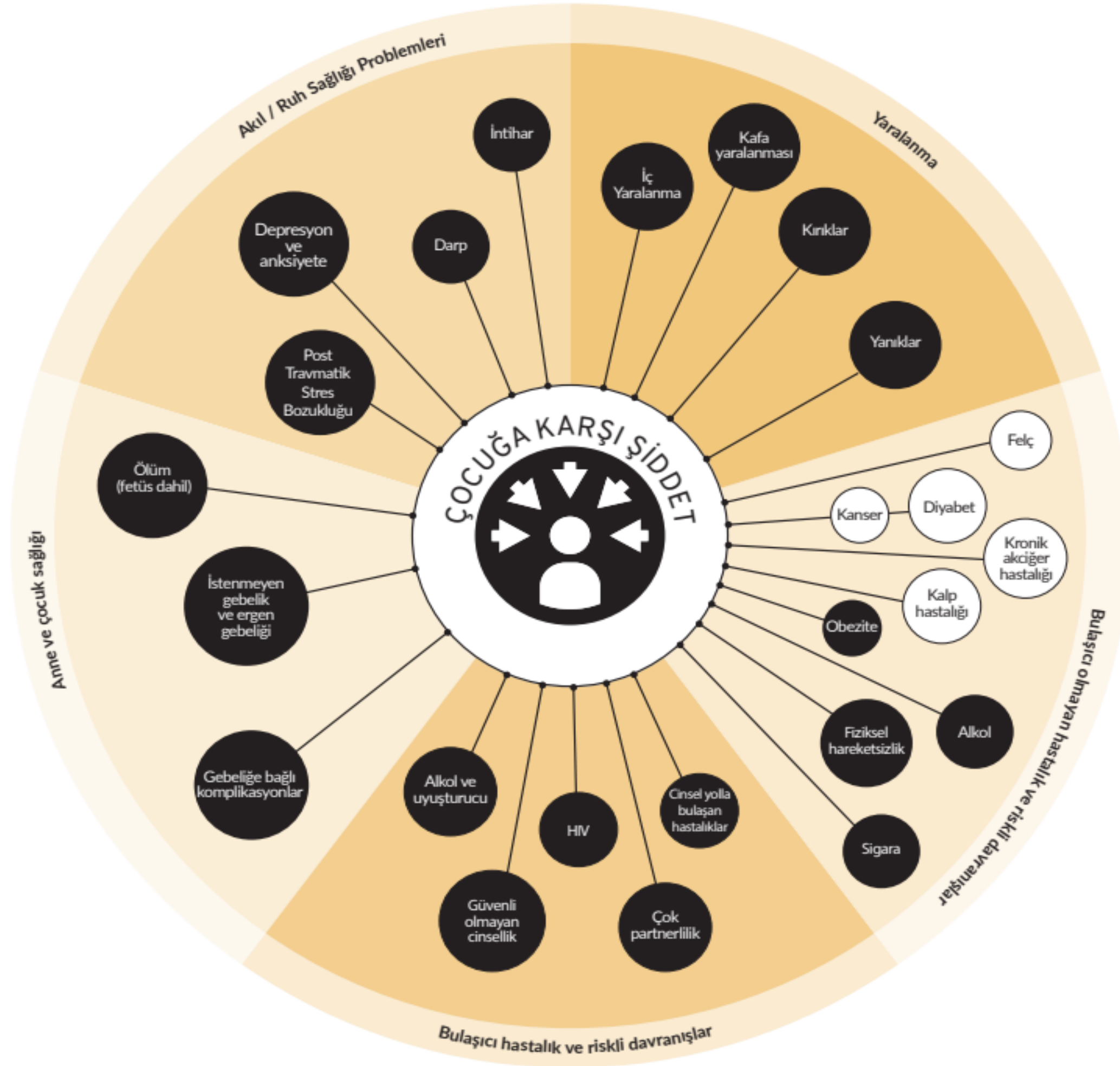
EKONOMİK İSTİSMAR

- Çocuğun gelişimini engelleyen, haklarını ihlal eden işlerde/ düşük ücretli işgücü olarak çalışması/ çalıştırılması ekonomik istismar olarak tanımlanmaktadır.
- Uzun süre ve uygunsuz alanlarda çalışan çocuklarda gelişimsel düzeylerine göre geri kalmalar görülmektedir. Çocuğun sadece ücretli bir işte değil evde küçük kardeşlerine bakmaya/ ev işlerini yapmaya zorlanmaları da ekonomik istismar anlamına gelmektedir.



ETKİLENEN YAŞ ARALIĞINA GÖRE ŞİDDET TÜRLERİ



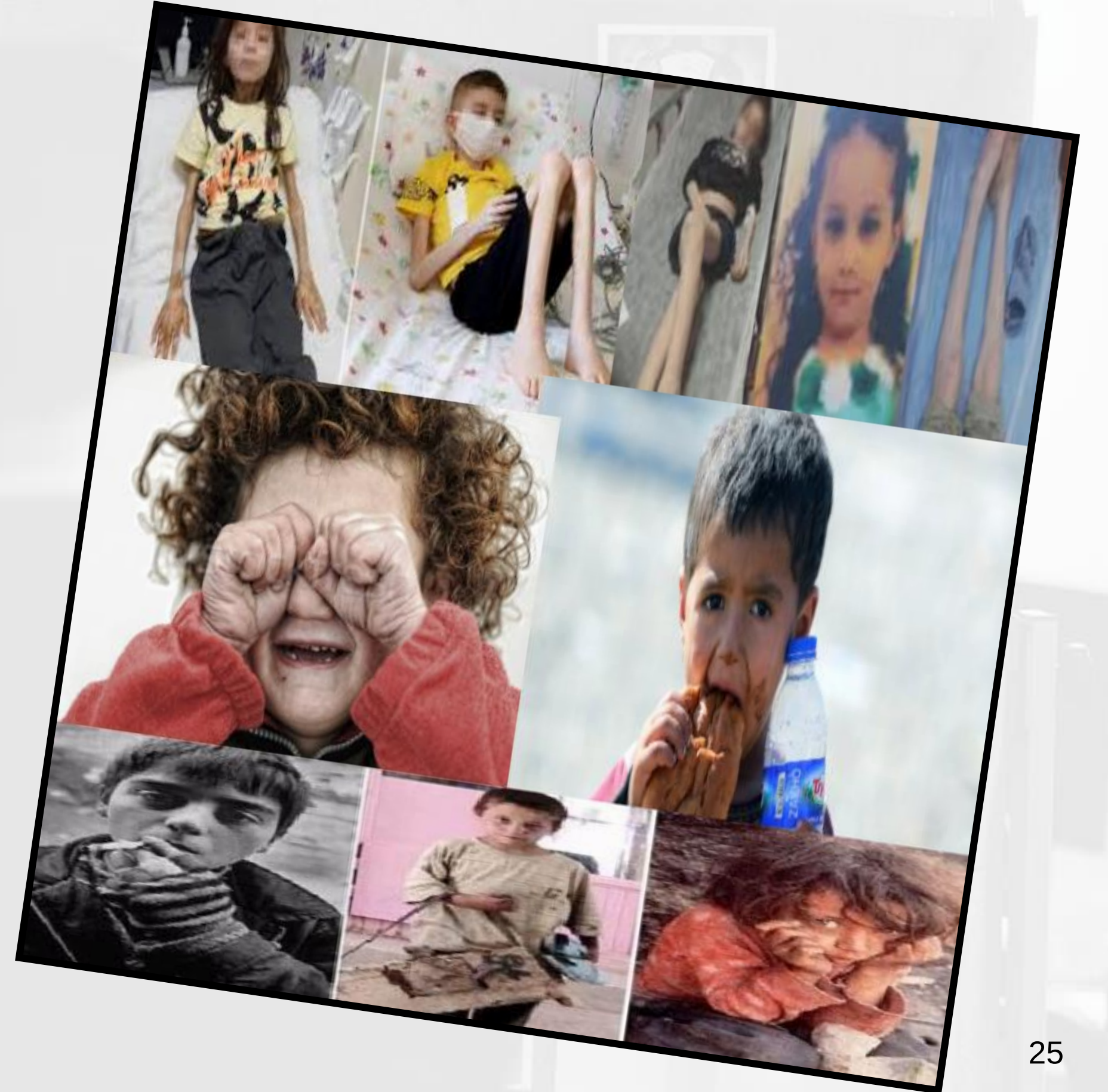


ÇOCUK İHMALİ

UNICEF'in Türkiye'deki aile içi şiddet ve çocuk istismarı 2010 raporunda, 7-18 yaş grubundaki çocukların dörtte birinin ihmale uğradıkları ve en çok yaşanan ihmal türünün yalnız bırakılma olduğu bildirilmektedir.

İhmal, çocuklara yönelik kötü muamele türlerinin en sık yaşanan türü olmakla birlikte literatürde gerektiği kadar incelenmediği belirtilmektedir

UNICEF'in Türkiye'deki aile içi şiddet ve çocuk istismarı 2010 raporunda, **7-18 yaş** grubundaki çocukların **dörtte birinin ihmale uğradıkları** ve en çok yaşanan ihmal türünün **yalnız bırakılma** olduğu bildirilmektedir. İhmal, çocuklara yönelik kötü muamele türlerinin en sık yaşanan türü olmakla birlikte literatürde gerektiği kadar incelenmediği belirtilmektedir .



İHMAL

• ÜLKEMİZDE

UNICEF işbirliği ile yapılan aile içi şiddet araştırması raporunda 7-18 yaş arasındaki çocukların % 56.0'sının fiziksel istismara, %49.0'unun duygusal istismara ve % 10.0'unun cinsel istismara tanık olduğu ve çocukların %25.0 'inin ihmale maruz kaldığı ifade edilmektedir (UNICEF, 2010).

• DÜNYADA

İncirkuş ve arkadaşlarının (2025) aktardığına göre Dünya' da çocuk ihmal ve istismarının boyutu tam olarak bilinmemekle birlikte, çocuk ihmal ve istismarının Dünya genelinde sıklığının incelendiği bir metaanaliz çalışmasında, fiziksel istismarın %22.6, cinsel istismarın %12.7, duygusal istismarın %36.3 oranında görüldüğü belirtilmektedir

FİZİKSEL BELİRTİLER

- Kötü vücut kokusu,
- Kirli cilt ve keçeleşmiş saçlar,
- Uygunsuz kıyafetler,
- Gelişim sürecindeki olumsuz ilerleme,
- Zayıf görünüş, düşük kilo,
- Karnın şişmesi ve bitlenme,
- Tedavi edilmeyen yara/diş çürükleri
- Erken yaşta evlilik,
- Madde bağımlılığı.

(İncirkuş ve ark., 2025)

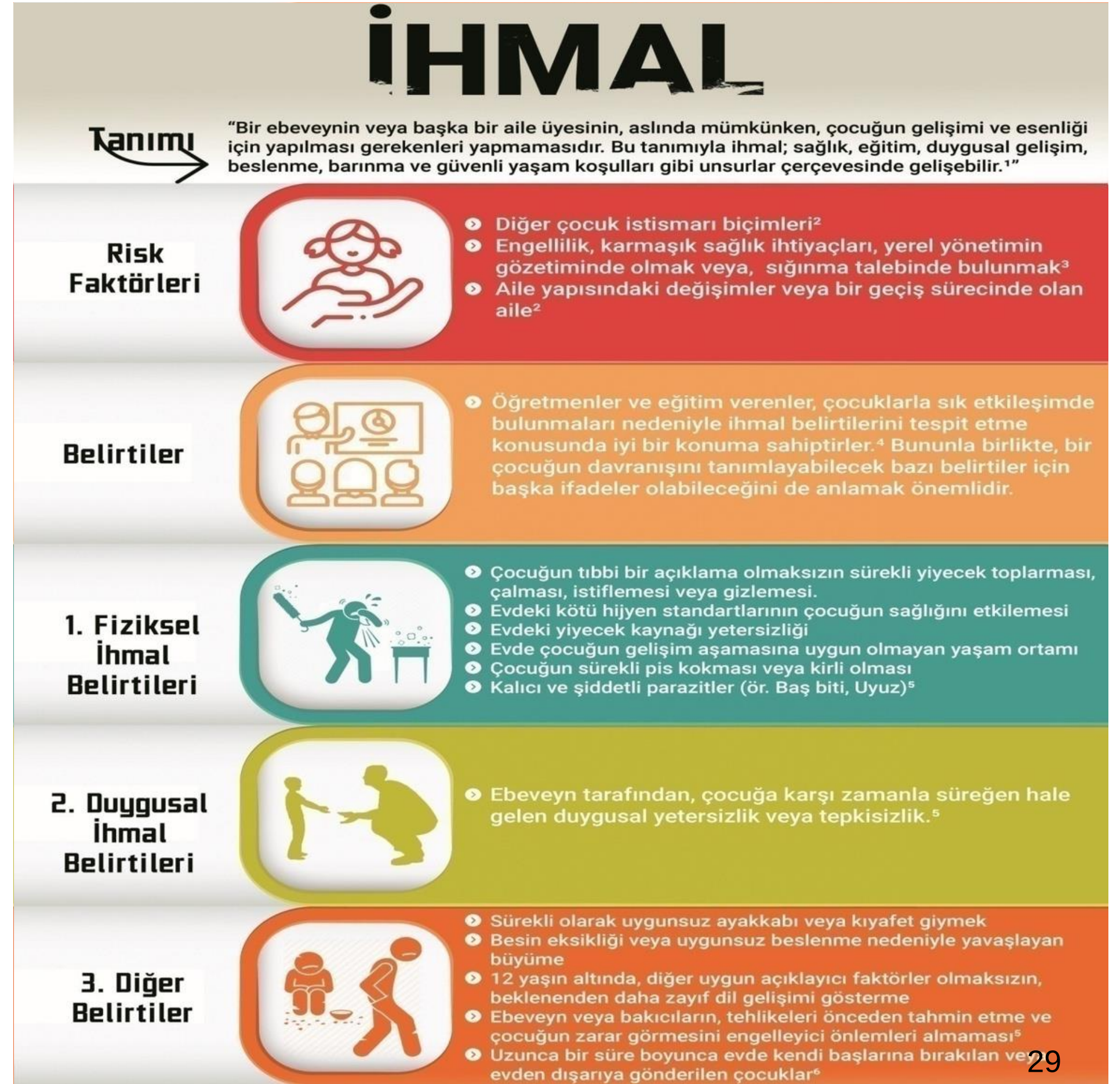
DAVRANIŞSAL BELİRTİLER

- Kendine zarar verme,
- Yiyecek çalma ve dilenme,
- Halsizlik, yorgunluk, derste uyuma,
- Yetişkin sorumlulukları yüklenme,
- Okula sürekli gecikme ve devamsızlık,
- Öz disiplin ve öğrenim eksikliği,
- Akademik başarısızlık,
- Öğrenme güçlüğü,

DUYGUSAL BELİRTİLER

- Kendisine değ er vermeme, d    k benlik algısı,
 - Baėlanma g      kleri,
 - Toplumsal problemler,
 - Az sayıda arkada  ilişkileri,
- Bireysel yakınlık kuramama,
 - Hal  sinasyon g  rme.

- Çocuk ihmal ve istismarının erken tanılanması, önlenmesi ve gerekli prosedürlerin uygulanmasında hemşirelere önemli görevler düşmektedir (Akcın & Yılmaz Güven,2024).
- Bu doğrultuda **DSÖ, hemşirelerin çocuk gelişim dönemlerini bilme, büyüme ve gelişmede normalden sapmaları tespit etme, anormal durumlarda gerekli prosedürleri bilme ve uygulama, birey, aile ve topluma gerekli eğitimleri verme gibi önemli sorumlulukları olduğunu vurgulamaktadır.**





Sağlık çalışanları bulguları fark edemediğinde, aileye sorgusuz bir şekilde inandığında, olumsuz geçmiş deneyimlerine veya ortamı sakinleştirmeye odaklandığında çocuklar istismar yaşadıkları yere geri gönderilebilmektedir.

Bu durum çocukların %35-50'inin çok ciddi zarar görmesine ve %5-10'unun ölümüne neden olabilmektedir (İncirkuş ve ark., 2025)



HER YIL EN AZ
41.000 ÇOCUK

İSTİSMAR VE İHMAL NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDİYOR!



Gerçek sayı daha yüksek olabilir!

Ölüm nedenieri farklı bildirildiği için gerçek rakam daha fazla olabilir.

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü



WHO

Çocuk istismarı ve ihmali; etiyolojisi, tanı ve tedavi süreçleri ile tüm boyutlarıyla karmaşık bir olgudur. Bu nedenle çocukların ihmal ve istismardan korunması, erken tanılanması, tedavi edilmesi ve rehabilitasyonu aşamalarında **multidisipliner bir ekibin birlikte çalışması gerekmektedir.**

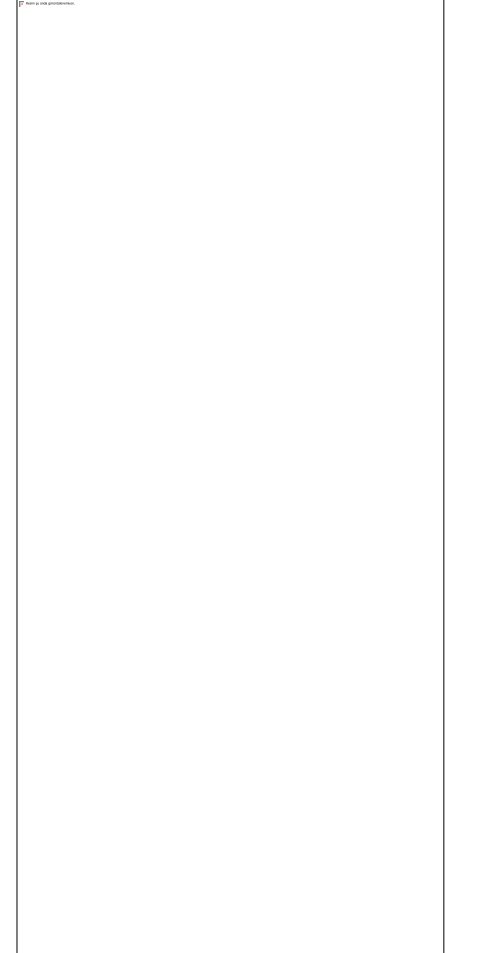
Hemşire, bu multidisipliner ekibin önemli bir üyesidir. Hemşireler; çocuk ihmal ve istismarına yönelik **çocuğa ve aileye ilişkin risk faktörlerinin farkında olarak, erken tanı sürecinde etkin rol üstlenmektedirler.**

Çocuk ihmal ve istismarının tanılanmasında ilk adım, **risk faktörlerinin** ve risk altındaki toplum gruplarının belirlenmesidir.

ÇOCUĞA YÖNELİK RİSK FAKTÖRLERİ

- Dört yaşın altında olmak
- Ergenlik döneminde bulunmak
- İstenmeyen bir gebelik sonucu dünyaya gelmek
- Özel gereksinimlere sahip olmak
- Zihinsel engel bulunması
- Nörolojik rahatsızlıklara sahip olmak
- Belirgin fiziksel farklılıkların bulunması
- Kendini trans, gey, lezbiyen veya biseksüel olarak

Ancak çocuđun bu risk faktörlerinden herhangi birine sahip olması, asla kötü muameleye maruz kalmasının gerekçesi olamaz. Çocuđun her durumda kurban olduđu ve sorumlu tutulamayacağı unutulmamalıdır (İncirkuş ve ark., 2025).



EBEVEYN/BAKICIYA YÖNELİK RİSK FAKTÖRLERİ

- Bebekle bağ kurmada ve bakımda zorluk yaşamak
- Kendi çocukluğunda kötü muameleye maruz kalmış olmak
- Nörolojik ya da zihinsel bir rahatsızlığa sahip olmak
- Gebelikte ve doğum sonrasında alkol veya uyuşturucu madde kötüye kullanımı
- Çocuk gelişimi konusunda yeterli bilgiye sahip olmamak
- Çocuğa yönelik gerçekçi olmayan beklentiler içinde olmak
- Düşük özsaygı düzeyi
- Zayıf dürtü kontrolü
- Suça karışmış olmak
- Düşük eğitim ve gelir düzeyine sahip olmak

AİLE VE SOSYAL ÇEVREYE AİT RİSK FAKTÖRLERİ

- Aile içi şiddetin varlığı
- Ailenin dağılması
- Toplumdan izole olma ve sosyal destek yetersizliği
- Erken veya zorla evlilik
- Suça eğilimli akranlarla ilişki
- Geniş aile desteğinin zayıflaması

TOPLUMSAL VE YAPISAL RİSK FAKTÖRLERİ

- Toplumsal ve cinsiyet eşitsizliği
- Aileleri ve kurumları destekleyecek yeterli konut ve hizmetlerin yetersizliği
- Şiddeti ve bedensel cezayı meşrulaştıran sosyal normlar
- Çocuğun statüsünü azaltan ve katı toplumsal cinsiyet rollerine dayalı kültürel yapılar
- Yüksek işsizlik ve yoksulluk
- Alkol ve uyuşturucu maddelere kolay erişim
- Çocuk istismarını ve sömürüsünü önlemeye yönelik yetersiz politika ve programlar
- Sosyoekonomik eşitsizlik
- Doğal afetler ve savaşlar
- Kötü yaşam koşulları ve toplumsal istikrarsızlık

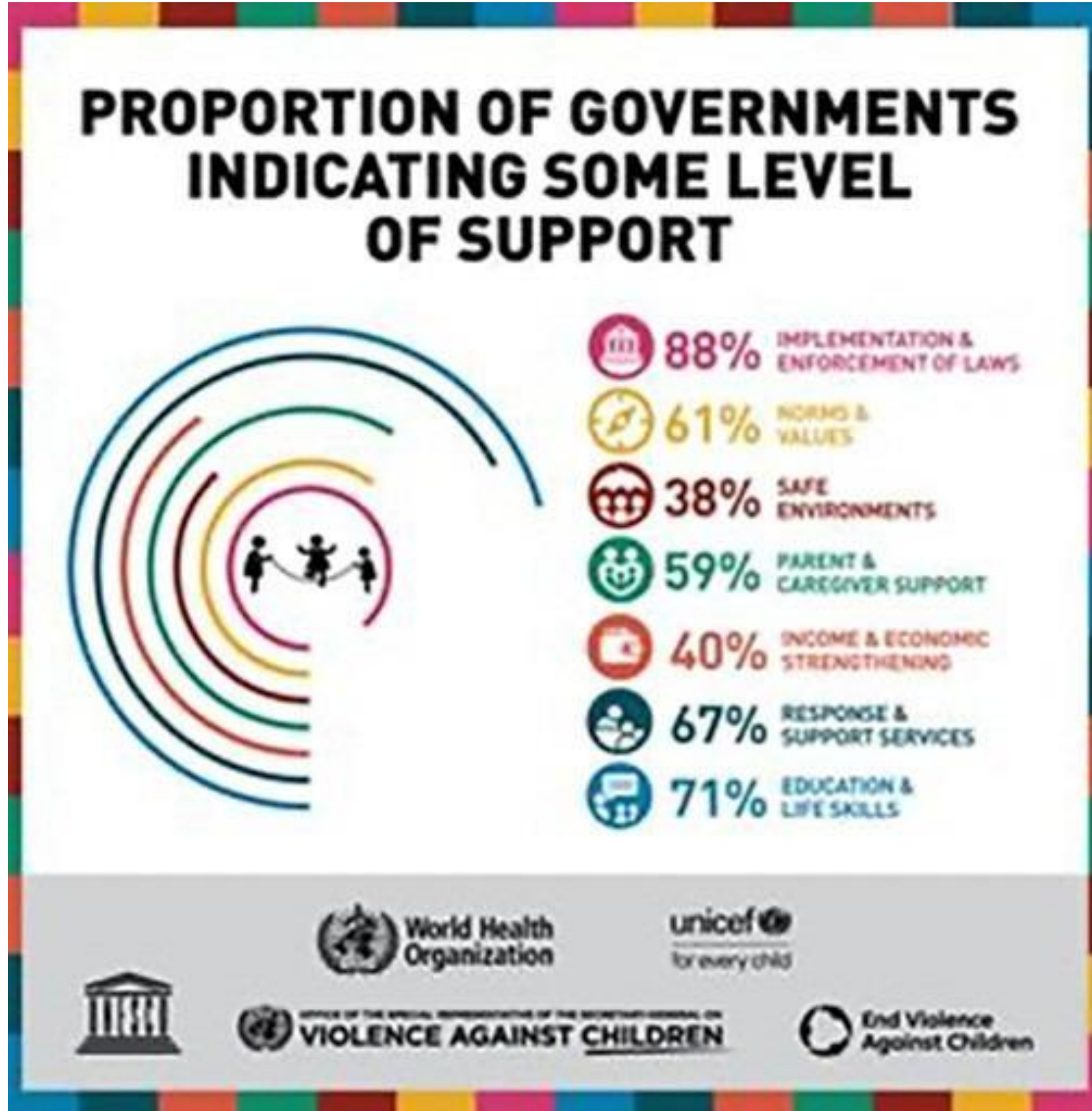
INSPIRE

Seven Strategies for Ending Violence Against Children

EXECUTIVE SUMMARY



- **I – Implementation and enforcement of laws**
(Yasaların uygulanması ve yaptırımların güçlendirilmesi)
- **N – Norms and values**
(Toplumsal normlar ve değerlerin dönüştürülmesi)
- **S – Safe environments**
(Güvenli çevrelerin oluşturulması)
- **P – Parent and caregiver support**
(Ebeveyn ve bakım verenlere destek)
- **I – Income and economic strengthening**
(Gelir ve ekonomik güçlendirme)
- **R – Response and support services**
(Müdahale ve destek hizmetleri)
- **E – Education and life skills**
(Eğitim ve yaşam becerileri)



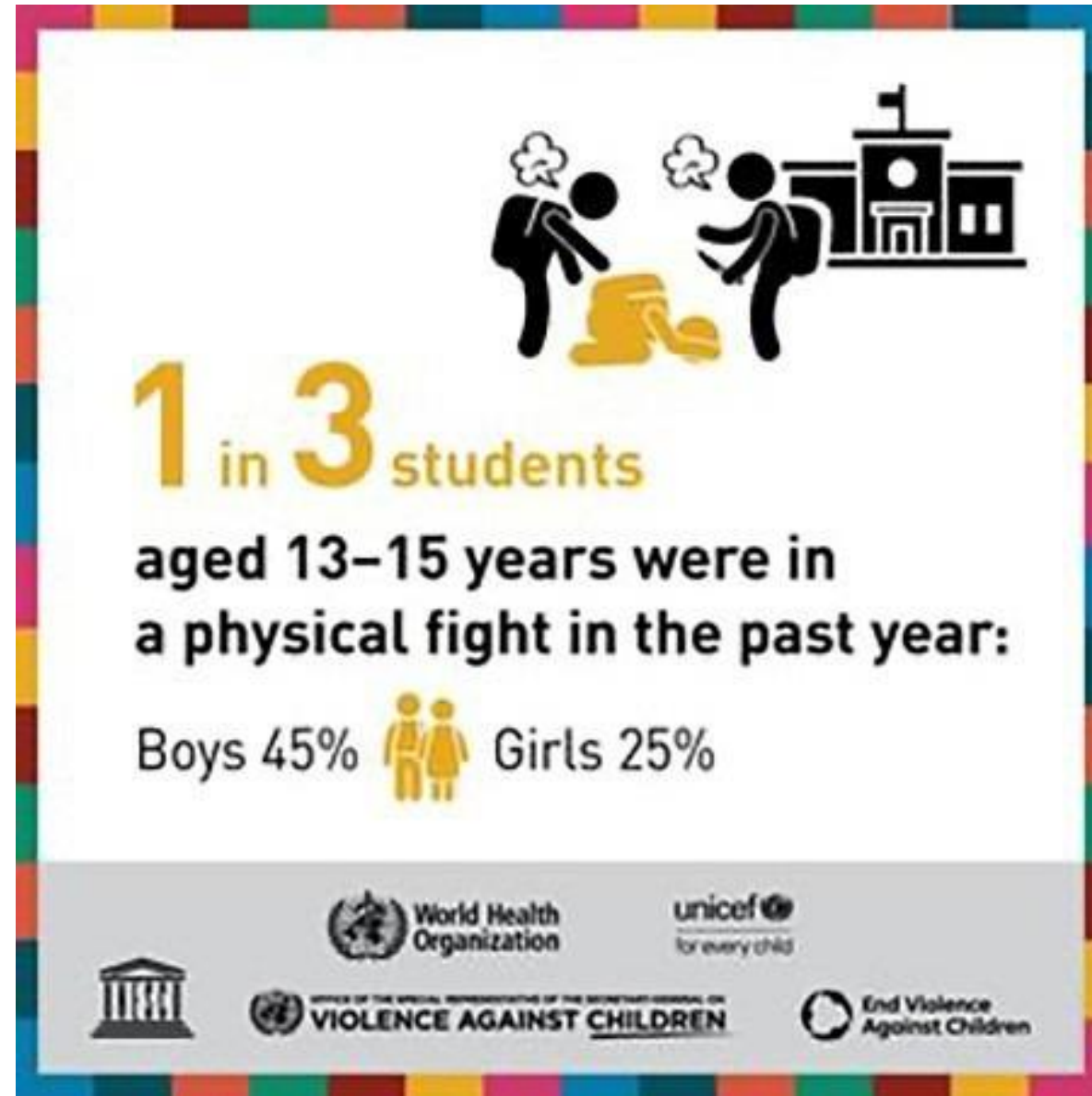
- Çocuk istismar ve ihmal alanında hükümetlerin **INSPIRE kriterlerini** *bazı düzeylerde* uyguladığı veya eriştiğini gösteren dağılımlara bakıldığında;
- %88'inin yasaların uygulanmasını ve yaptırımların sağlandığı,
- %61'inin normlar ve değerleri önemseddiği,
- %38'inin güvenli ortamların desteklediği,
- %59'unun ebeveyn ve bakıcıları desteklediği,
- %40'ının gelirin ve ekonomik güçlenmeyi desteklediği,
- %67'inin müdahale ve çocuk yararı koruma hizmetlerinin desteklendiği
- %71'inin çocuğun eğitim ve sosyal becerilerini desteklediği belirtmiştir.



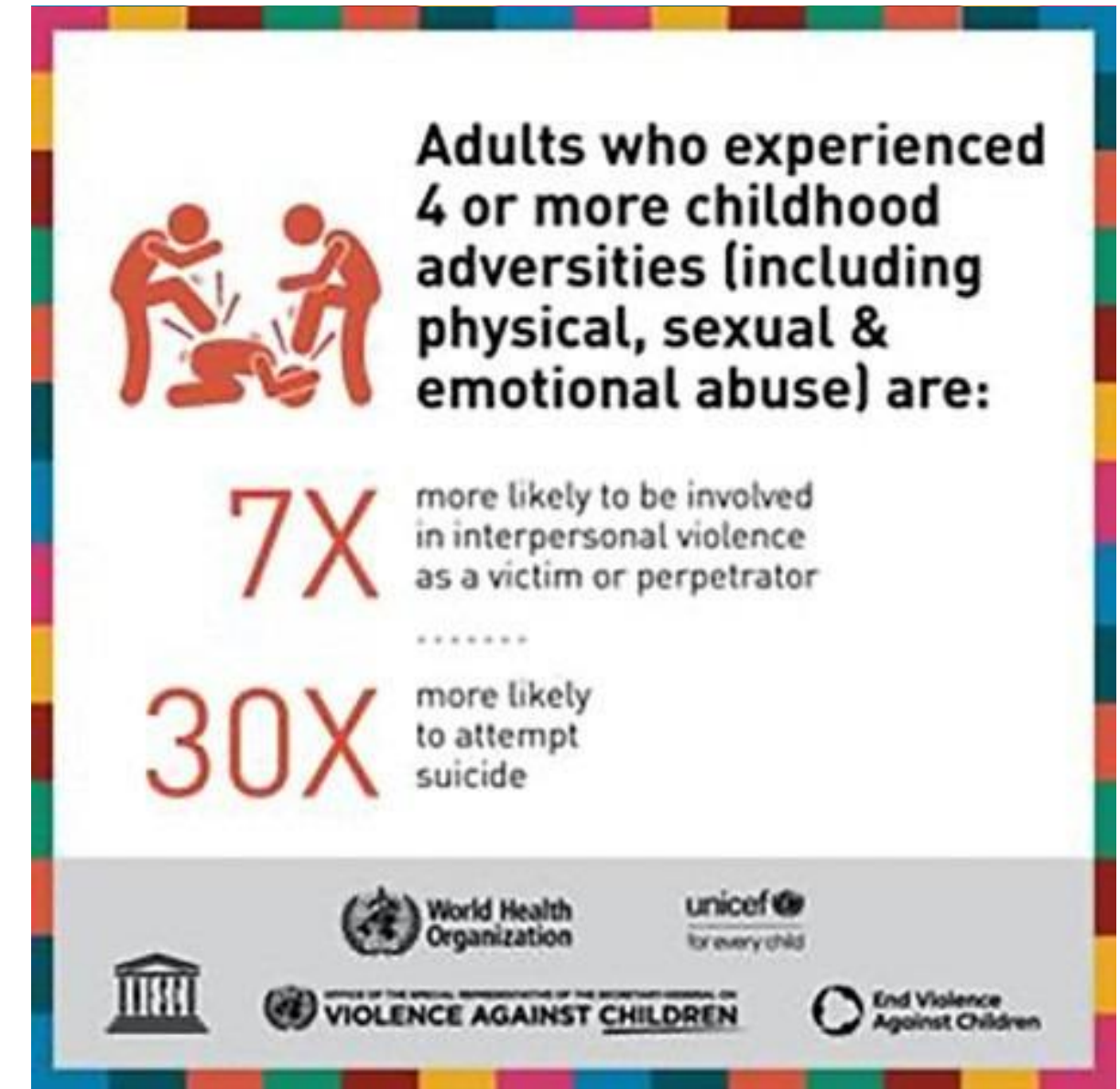
Dünyada her yıl 2 çocuktan 1'inin veya 1 milyon çocuğun istismarın herhangi bir türüne maruz kaldığı gösterilmiştir.



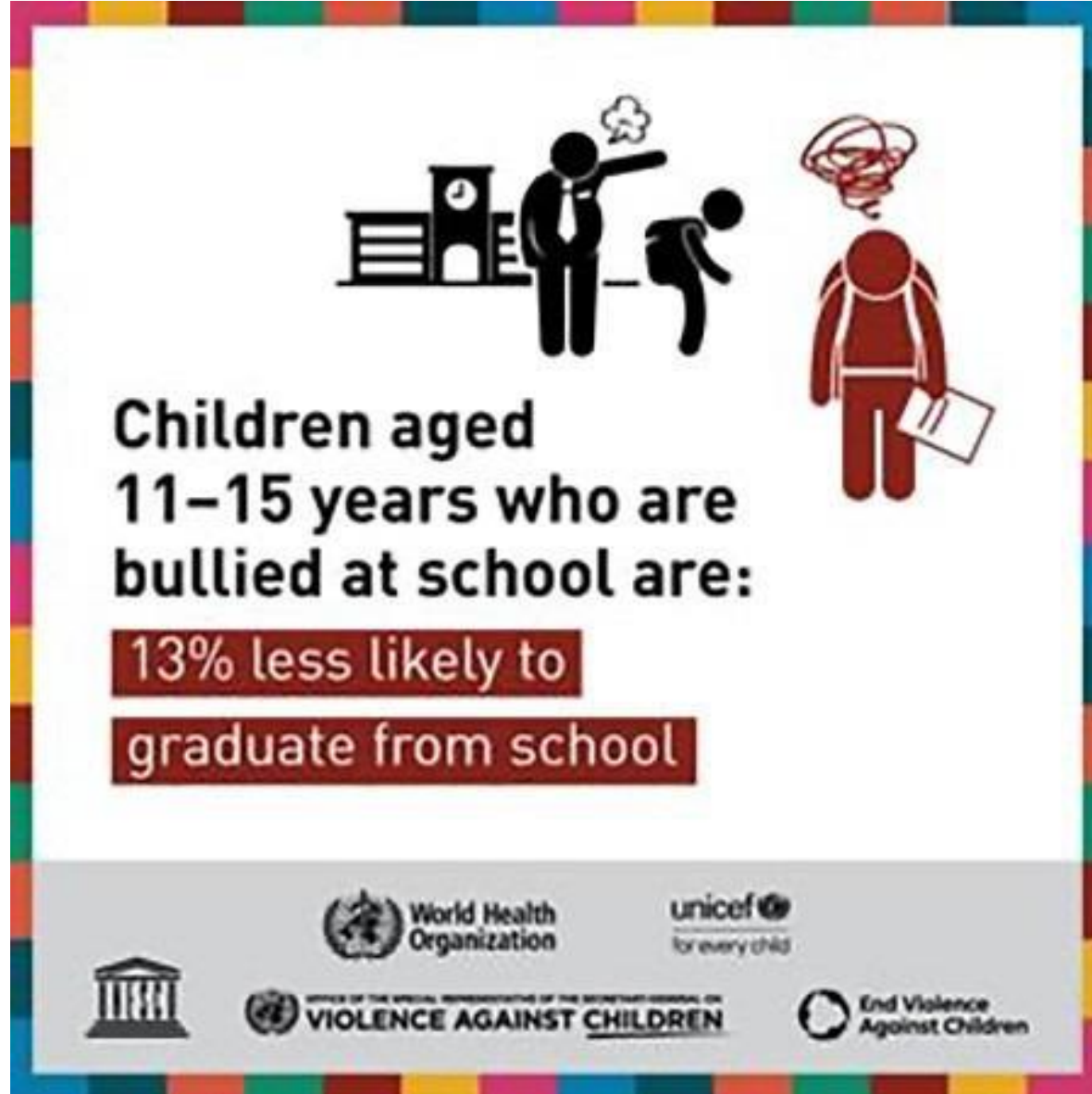
5 yaş altındaki her 4 çocuktan birinin annesinin yakın partner şiddeti yaşadığı gösterilmiştir.



Bir önceki yıl 13-15 yaş arasında her 3 öğrenciden 1'inin fiziksel bir kavgaya karıştığı, bu oranın erkek çocuklarda %45'i, kız çocuklarında %25 olduğu gösterilmiştir.



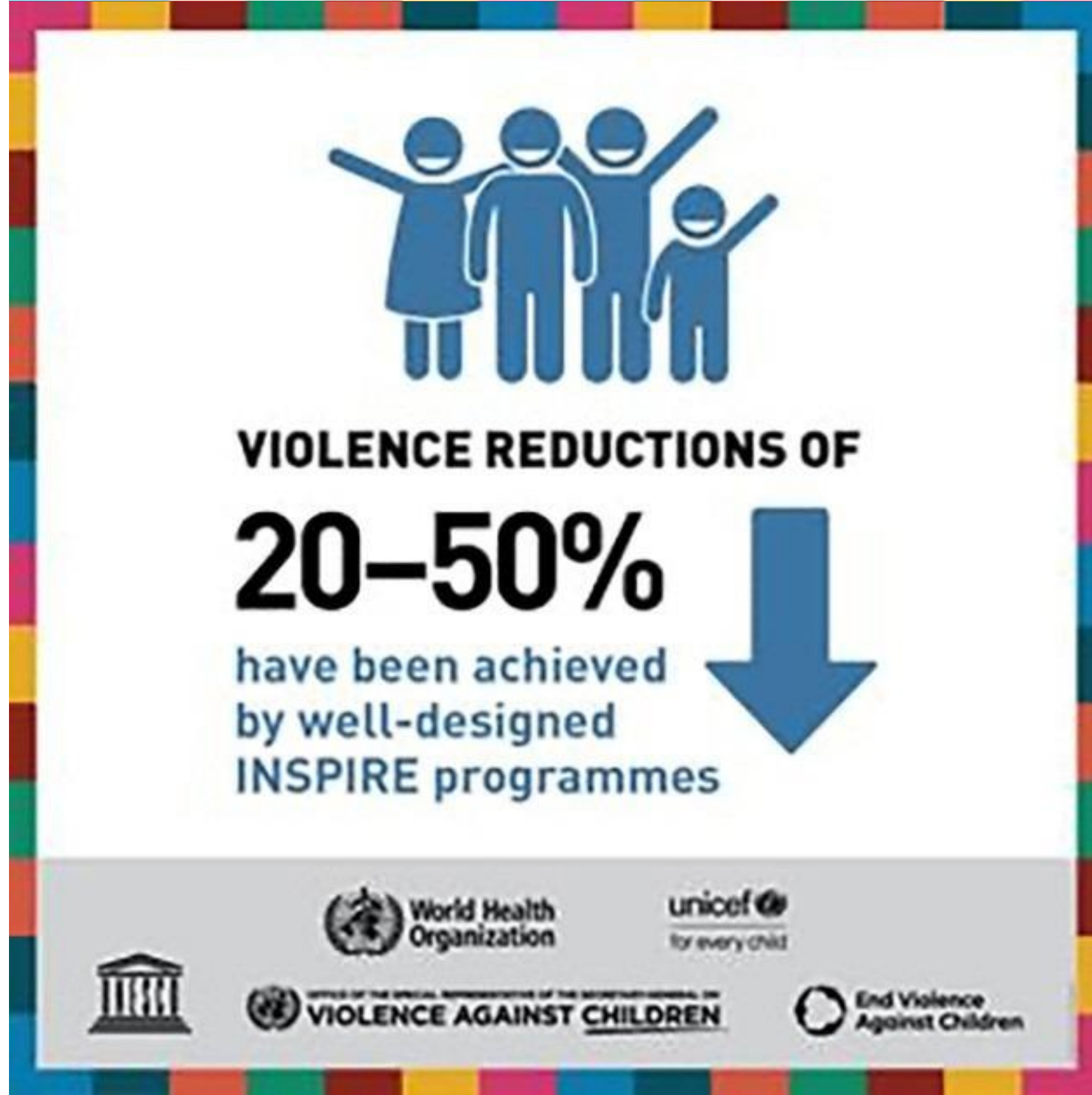
Yetişkinlerden her 4 kişiden 1'inin çocukluk döneminde fiziksel ve cinsel ve duygusal istismara maruz kaldığı, bu erişkinlerin kişilerarası şiddette mağdur ya da fail olma olasılığının 7 kat daha fazla olduğu, intihara eğilimlerin 30 kat arttığı gösterilmiştir



Okul döneminde zorbalığa uğradığı bilinen 11-15 yaş arası çocukların %13'den daha az bir ihtimalle mezun olabildiği gösterilmiştir .



Bir önceki ay 11-15 yaş arasında her 3 öğrenciden 1'inin akran zorbalığına maruz kaldığı, bu oranın erkek çocuklarda %35'i, kız çocuklarında %30 olduğu gösterilmiştir.



INSPIRE kriterlerine uyum ile Çocuk İstismar ve İhmalinin %20-50 oranında azaltıldığı saptanmıştır.

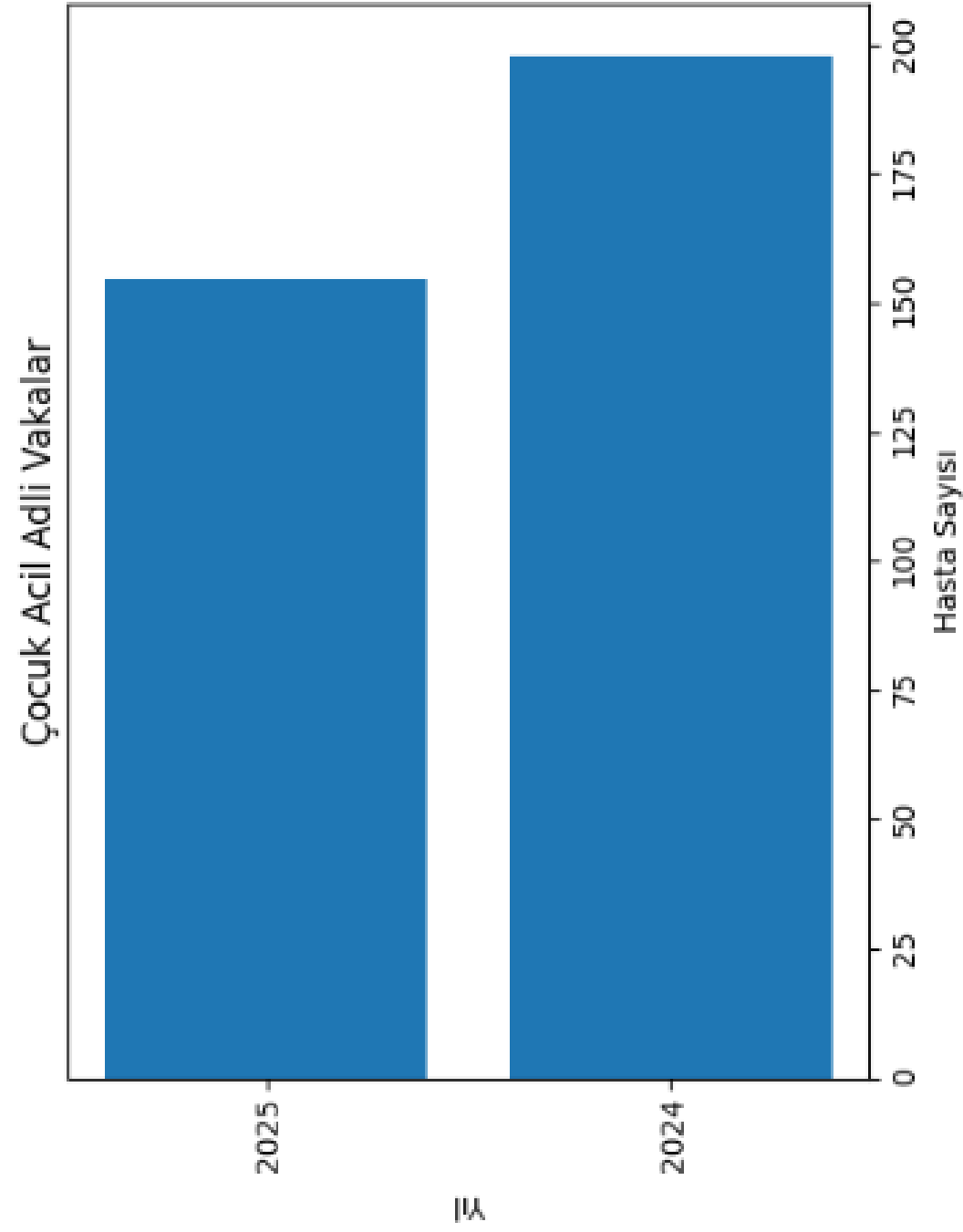


HASTANEMİZDE

- 2025 YILI ADLİ VAKA BİLDİRİMİ :2936 VAKA
- 2024 YILI ADLİ VAKA BİLDİRİMİ: 3509 VAKA

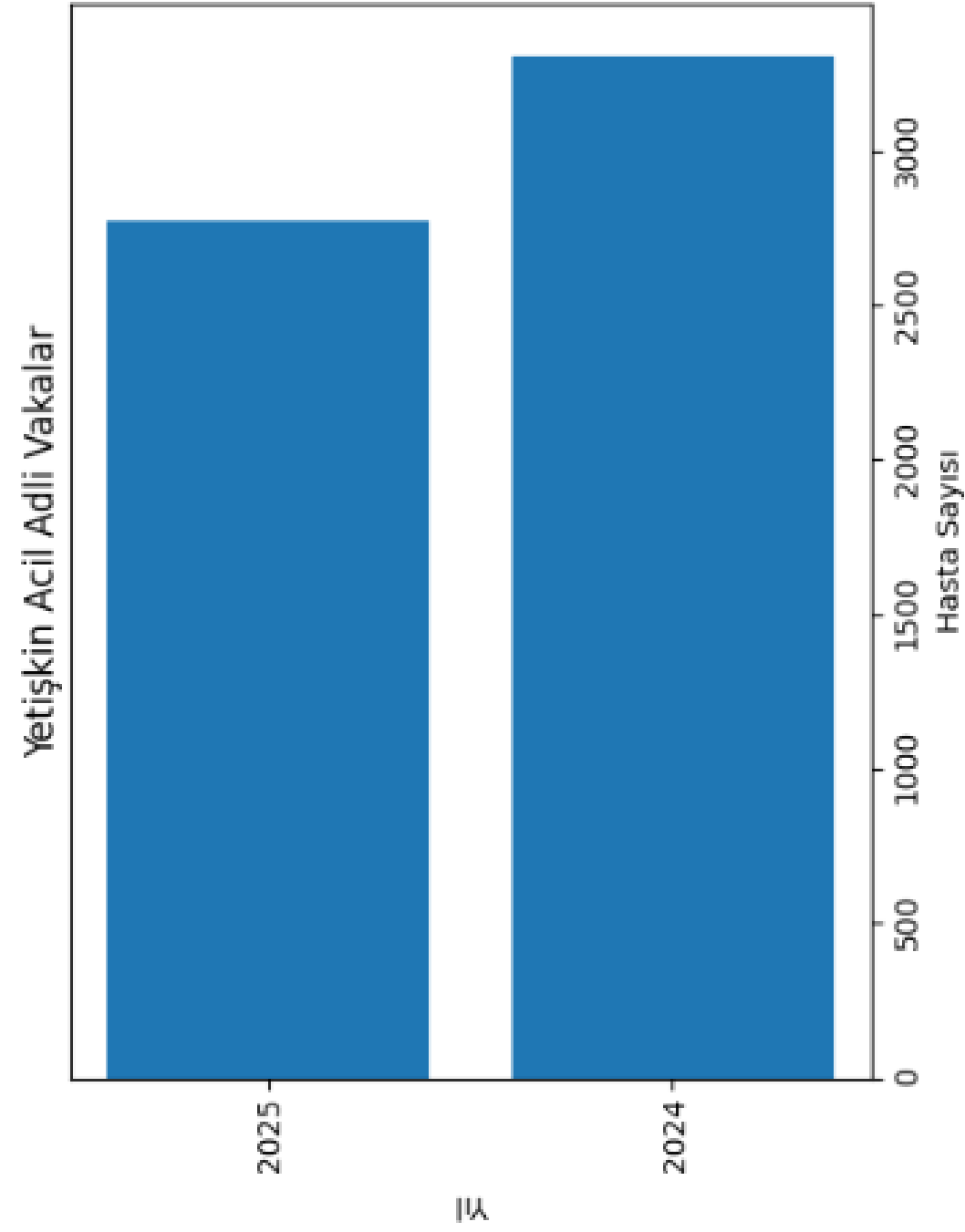
ADLİ TIP POLİKLİNİĞİNDE

- 2025 YILI TOPLAM HASTA SAYISI :1048 HASTA
- 2024 YILI TOPLAM HASTA SAYISI :1168 HASTA



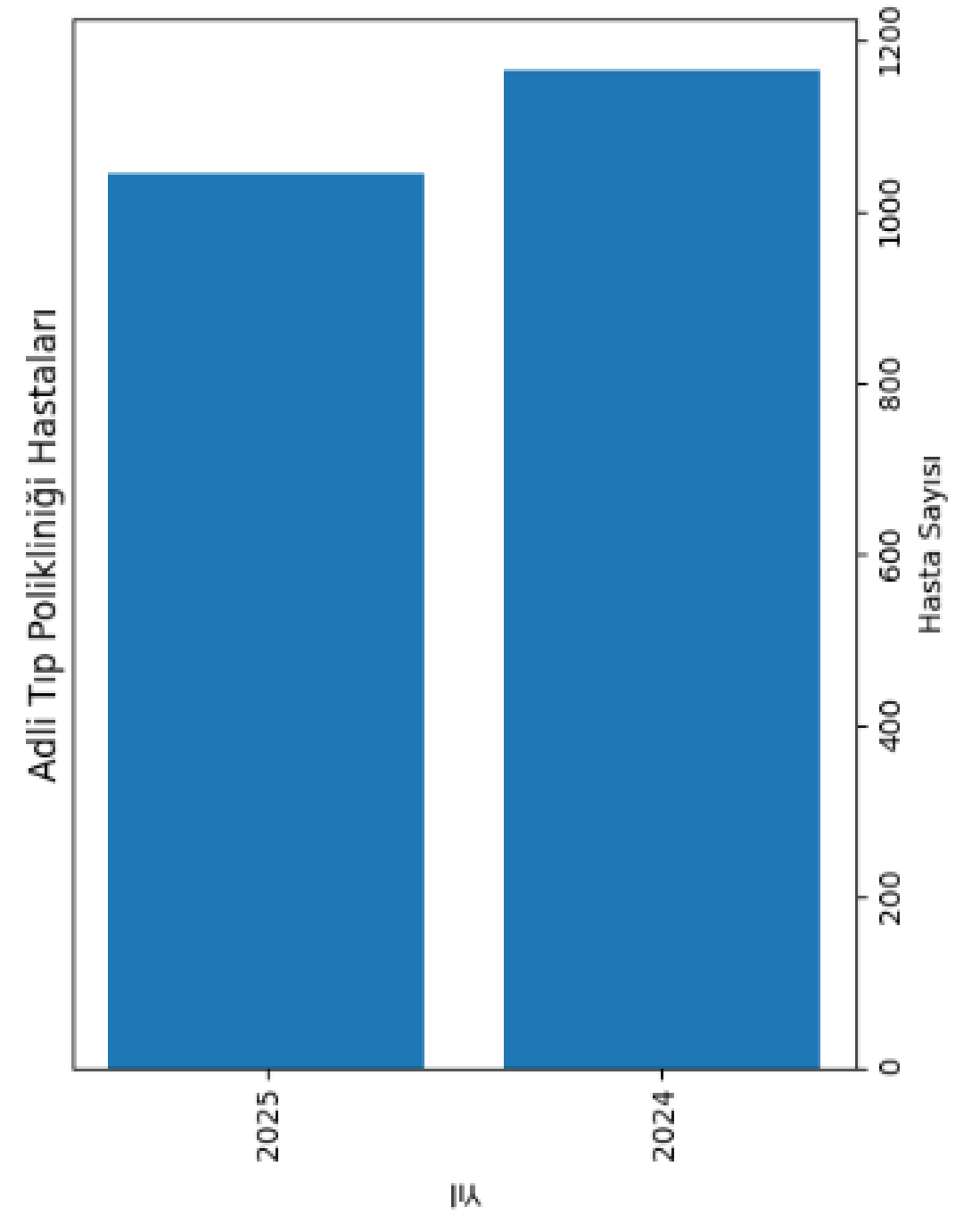
ÇOCUK ACİL SERVİSİ

2025 YILI :155 HASTA
2024 YILI:198 HASTA



YETİŞKİN ACİL SERVİSİ

2025 YILI :2782 HASTA
2024 YILI :3311 HASTA



ADLİ TIP POLİKLİNİĞİ

2024 YILI		2025 YILI	
0-17 YAŞ :	214 HASTA	0-17 YAŞ:	195 HASTA
18 <.... :	954 HASTA	18<.... :	853 HASTA

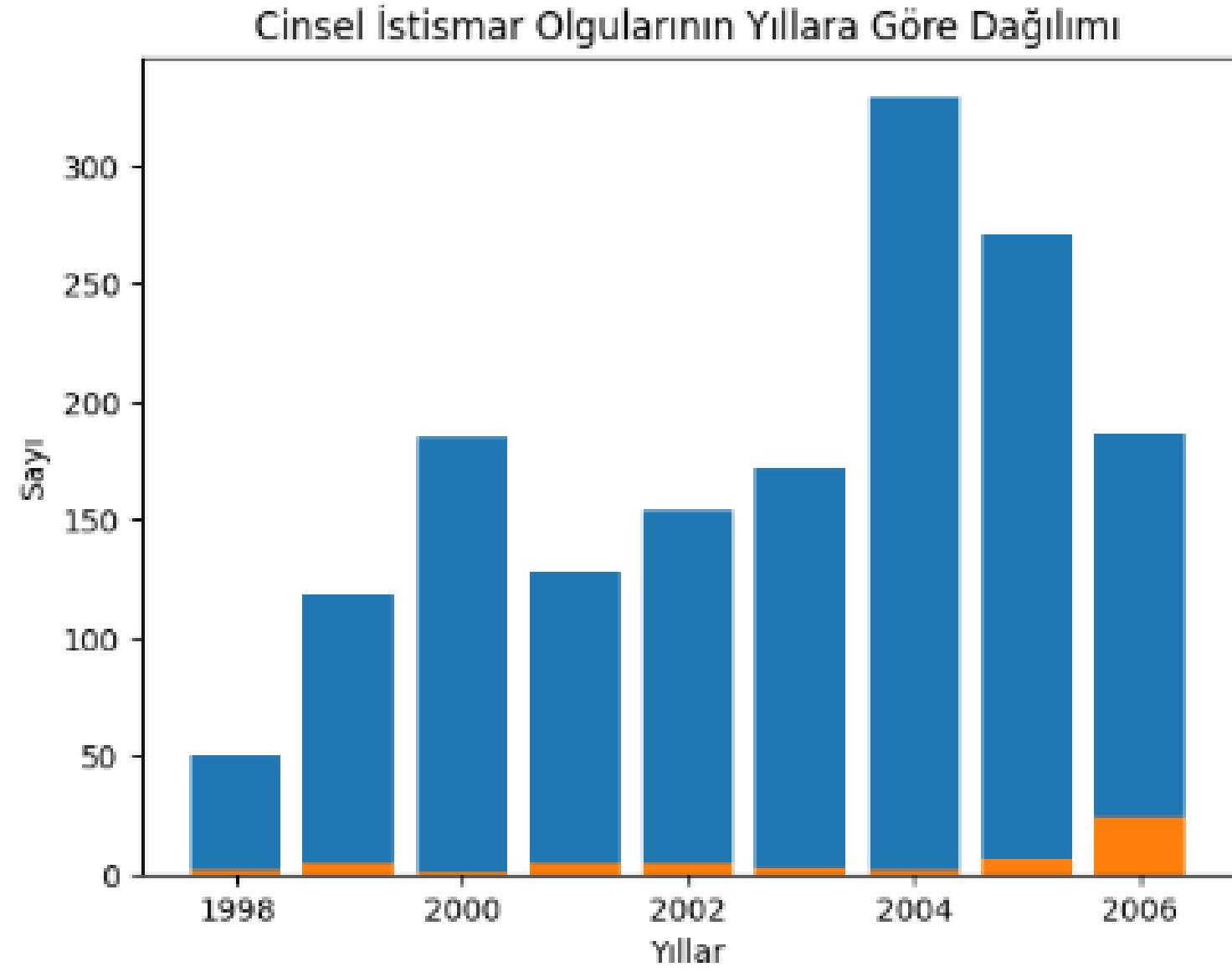
ÇALIŞMALAR

Çolak ve arkadaşlarının (2009) , 1998–2006 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na başvuran adli olgular retrospektif olarak incelenmiştir.

Toplam 1594 adli rapordan, çocuklara yönelik cinsel istismar kapsamında yer alan **50 olgu** (%3,1) çalışmaya dahil edilmiştir. Olgulara ait Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı hasta dosyaları da değerlendirilmiş, olgu seçiminde, 18 yaşın altında olup cinsel eyleme maruz kaldığı iddia edilen tüm çocuklar sanık yaşı gözetilmeksizin çalışmaya alınmıştır.

- Adli raporların düzenlendiği yıl
- Yaş grubu
- Cinsiyet
- Olay yeri
- Mağdur–sanık arasındaki yakınlık derecesi
- Olay tarihi ile muayene tarihi arasında geçen süre
- İlk muayenenin yapıldığı sağlık kuruluşu
- Fiziksel muayene dışında başvuru tanı yöntemleri
- Cinsel istismarın özellikleri
- Ruhsal muayene sonuçları

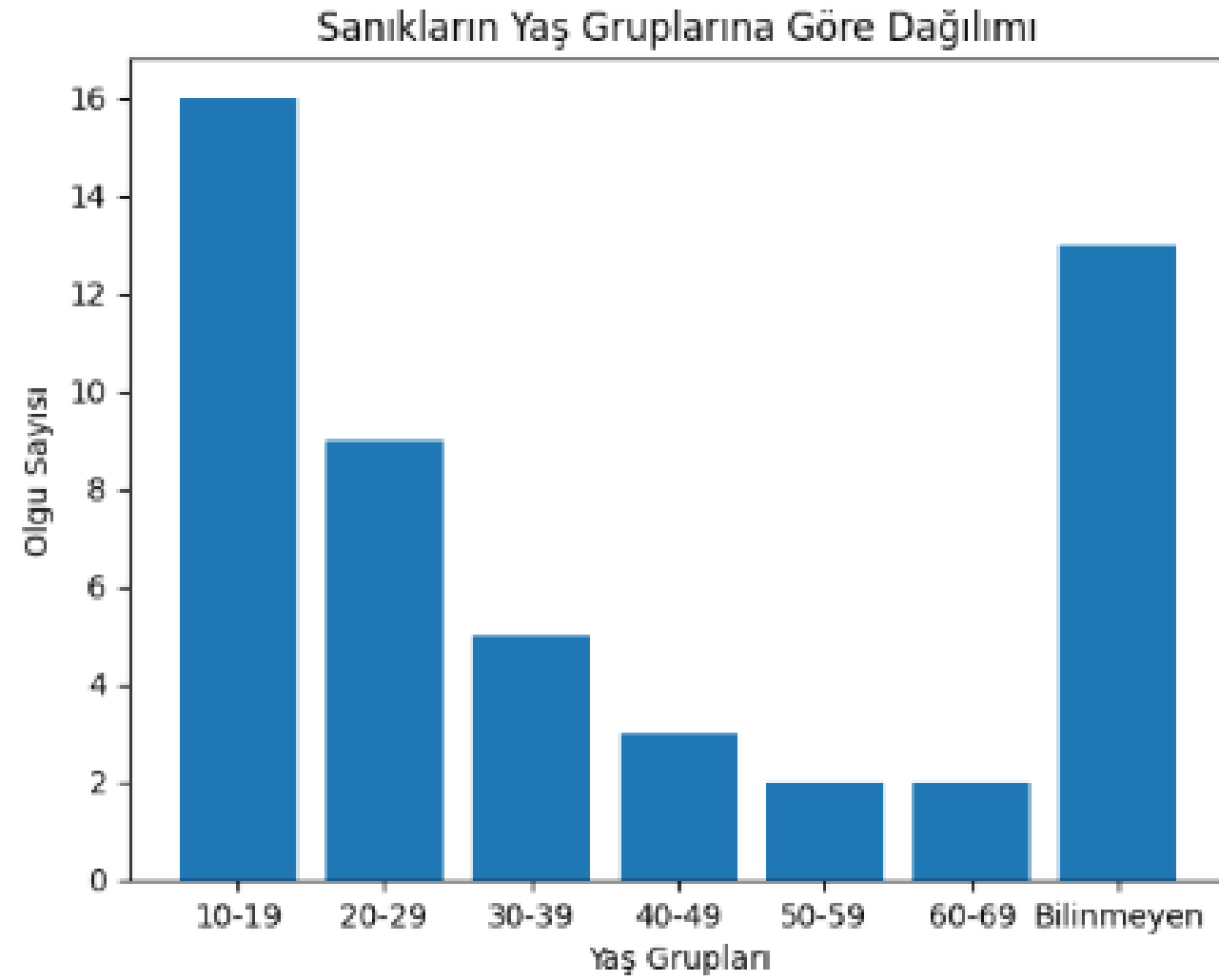
Grafik 1: Cinsel İstismar Olgularının Yıllara Göre Dağılımı
Çolak ve ark., (2009)



Yıl	Toplam rapor sayısı	Olgu sayısı
1998	50	2
1999	118	4
2000	185	1
2001	128	4
2002	154	4
2003	172	3
2004	329	2
2005	271	6
2006	187	24

Grafik 2 – Sanıkların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Çolak ve ark., (2009)



Yaş grubu	Olgu sayısı
10-19	16
20-29	9
30-39	5
40-49	3
50-59	2
60-69	2
Bilinmeyen	13

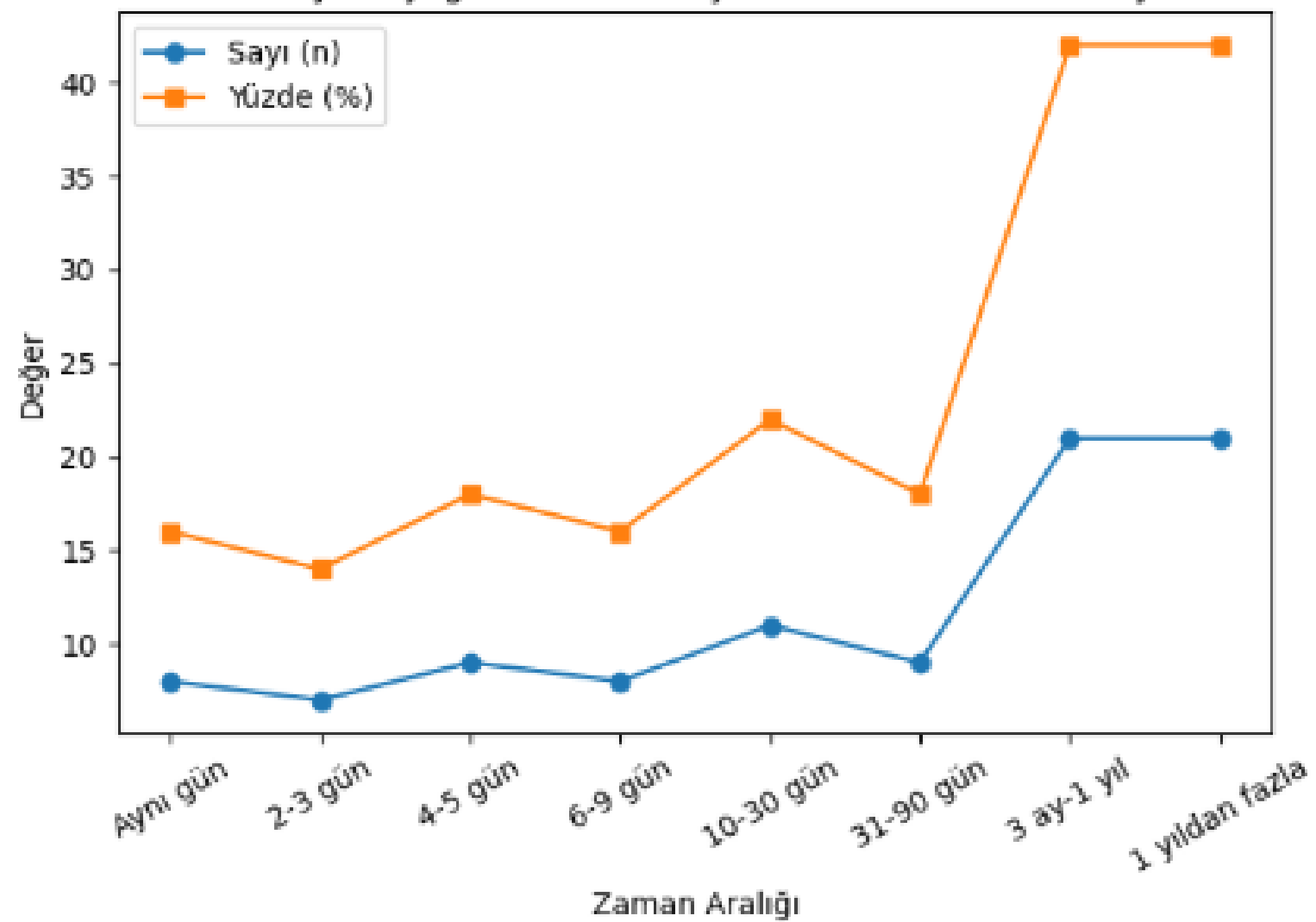
Tablo 1: Olguların yaş grubu ve cinsiyete göre dağılımı

Çolak ve ark., (2009)

Yaş grubu	Kadın (n)	Kadın (%)	Erkek (n)	Erkek (%)	Toplam (n)	Toplam (%)
≥7*	5	16,1	5	26,3	10	20
8–11**	8	25,8	12	63,1	20	40
12–15***	8	25,8	1	5,3	9	18
16–18****	10	32,3	1	5,3	11	22
Toplam	31	100	19	100	50	100

Grafik 3: İstismarın Gerçekleştiği Tarih ile Muayene Tarihi Arasında Geçen Sürenin Dağılımı

Çolak ve ark., (2009)



- Cinsel istismar olgularının, eylemin üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra Adli Tıp Anabilim Dalı'na yansıdığı saptanmıştır (Grafik 3).
- Olgulardan birinin, olaydan yaklaşık 4 yıl sonra muayene edilmek üzere Anabilim Dalı'na gönderildiği belirlenmiştir.
- Suç tarihinden 10 günden daha kısa süre içinde adli birimlere yansıyan olguların oranının %34 olduğu saptanmıştır.

Grafik 3: İstismarın Gerçekleştiği Tarih ile Muayene Tarihi Arasında Geçen Sürenin Dağılımı - devamı

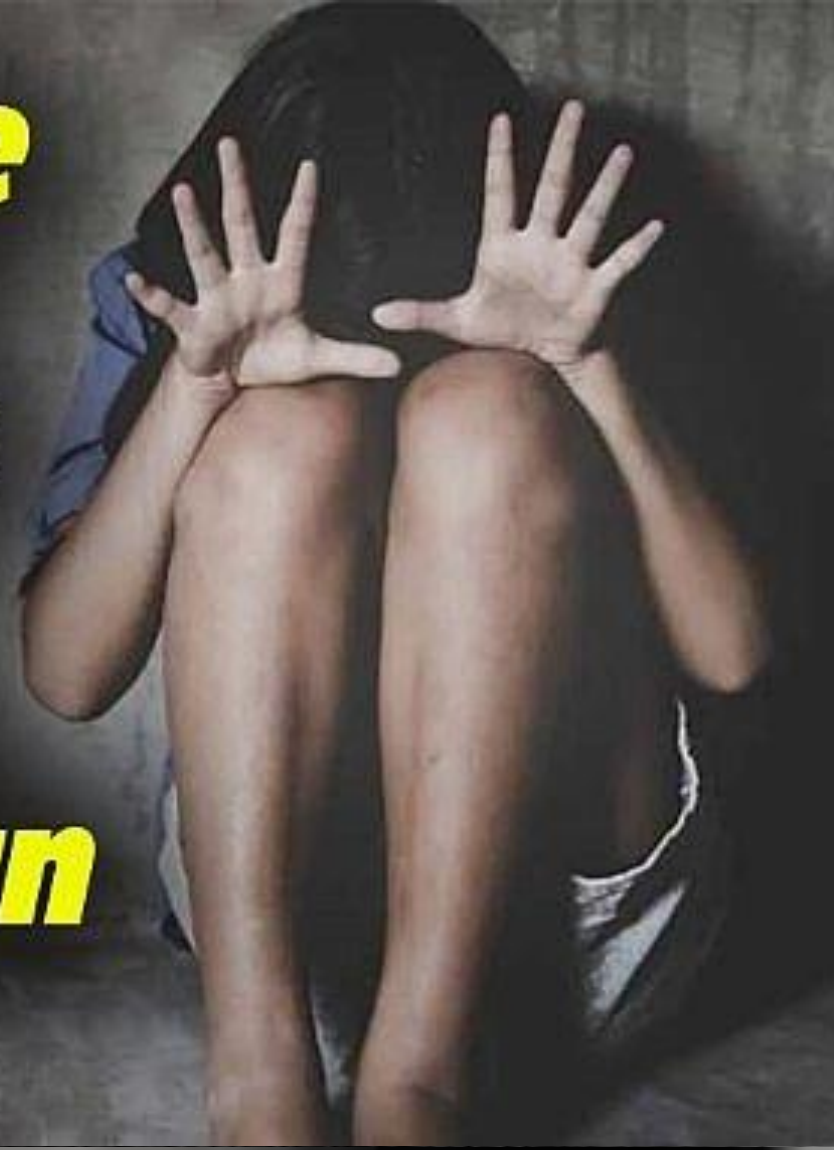
Zaman aralığı	Olgu sayısı (n)	%
Aynı gün	8	16
2-3 gün	7	14
4-5 gün	9	18
6-9 gün	8	16
10-30 gün	11	22
31-90 gün	9	18
3 ay – 1 yıl	21	42
1 yıldan fazla	21	42

Alt açıklama:

n: olgu sayısı, %: yüzde

- Olguların %22'sinin, olaydan yıllar sonra adli makamlara yansıdığı belirlenmiştir (Çolak ve ark., 2009) .
- İddia edilen suç tarihi ile olayın adli makamlara yansımaları arasında önemli bir gecikme olduğu saptanmıştır (Çolak ve ark., 2009).
- Olgulara ait yargılama süreci takip edilemediğinden, davaların ne kadar sürede sonuçlandığına ilişkin bilgi elde edilememiştir (Çolak ve ark., 2009) .

**Yeğenlerine
cinsel
istismarda
bulunan
amcadan
kan donduran
ifade**



**ÜVEY TORUNUNA
CİNSEL İSTİSMAR
DAVASINDA TUTUKLAMA**

www.uyanik2.com www.kfkgos.com www.tsi2.com.tr



**Bolu'da
cinsel istismar
saniğına
rekor ceza!**

**Hem de
öz babası**

**8 çocuğa
zincirleme
cinsel
istismar!**



**ÖĞRETMENE
BÜYÜK CEZA!**



**SINIF ÖĞRETMENİ CİNSEL İSTİSMAR
İDDİASIYLA TUTUKLANDI!**

**İzmir'de
iğrenç
olay!**

14 yaşındaki kıza, 3 kış...



**ENİŞTESİNDEN
CİNSEL İSTİSMAR**

14 yaşındaki kız çocuğuna

53



Tablo 2: Mağdur–sanık arasındaki yakınlık derecesinin dağılımı
(Çolak ve ark., 2009)

Yakınlık derecesi	n	%
Eşi	1	2
Öz baba	4	8
Üvey baba	1	2
Üvey kardeş	1	2
Öğretmen	1	2
Arkadaş	7	14
Tanıdık (akraba, komşu, diğer tanıdık)	20	40
Yabancı	8	16
Kayıt yok	7	14
Toplam	50	100

Tablo 3: Cinsel istismarın gerçekleştiği olay yerlerinin dağılımı
(Çolak ve ark., 2009)

Olay yeri	n	%
Sokak, park, orman vb.	14	28
Ortak ev	7	14
Sanığın evi	11	22
İnşaat, boş bina, kömürlük	5	10
Mağdurun evi	2	4
İş yeri	2	4
Okul	1	2
Dükkan	3	6
Kayıt yok	5	10
Toplam	50	100

Tablo 4: Olguların İlk Başvurduğu Sağlık Birimlerinin Dağılımı
(Çolak ve ark., 2009)

Olguların İlk Başvurduğu Sağlık Birimlerinin Dağılımı	n	%
Devlet Hastanesi	32	64
SSK Hastanesi	2	4
Sağlık Ocağı	1	2
Üniversite Hastanesi Acil Servisi	2	4
Adli Tıp Anabilim Dalı	9	18
Adli Tıp Şube Müdürlüğü	3	6
Muayenehane	1	2
Toplam	50	100

Alt açıklama:

n: olgu sayısı, %: yüzde

Tablo 5: Cinsel İstismar İddialarının Dağılımı
(Çolak ve ark., 2009)

Cinsel istismarın şekli	n	%
Genital bölgelere dokunma	13	26
Vajinal penetrasyon	11	22
Anal penetrasyon	17	34
Anal ve vajinal penetrasyon	6	12
Taciz	3	6
Toplam	50	100

Alt açıklama:

n: olgu sayısı, %: yüzde

Tablo 6: Olgularda saptanan ruhsal tanıların dağılımı
(Çolak ve ark., 2009)

Ruhsal değerlendirme	n	%
Akut Stres Bozukluğu	12	24
Travma Sonrası Stres Bozukluğu	4	8
TSSB – Major Depresyon	7	14
Psikopatoloji Yok	6	12
Kontrol muayenesine gelmemiş	3	6
Olayla ilgisiz hastalık	1	2
Muayene yok	17	34
Toplam	50	100

Alt açıklama:

n: olgu sayısı, %: yüzde

İstersen tabloyu:

- *Yeni Zelanda’da adli bilim insanları tarafından, acil servis hemşirelerinin adli tıp protokolleri ile ilgili bilgilerini ve bu protokollere ne kadar uyduklarını tespit etmek amacıyla yapılan çalışmada; katılımcıların %76’sı kanıt toplama prosedürlerini bilmediklerini, %25’i ise kanıtların doğru bir şekilde toplanıp, teslim edilmesindeki süreçte kendilerinden emin olmadıklarını bildirmişlerdir (Donaldson, 2022).*
- *Silva ve ark. (2022) tarafından yapılan çalışmada, acil servislerde çalışan sağlık profesyonellerinin çoğunun adli vakalar ile ilgili eğitim, bilgi ve becerilerinin yetersiz olduğu vurgulanmış, Karabulutlu ve ark. (2023) tarafından yapılan çalışmada ise acil serviste çalışan hekim, hemşire ve ebelerin adli vaka, adli hemşirelik ile ilgili bilgi almadıkları ve adli vakalara yaklaşımla ilgili okullarda eğitim verilmesi gerektiği ifade etmiştir.*

- **Bozbuğa, Çalışkan ve Özdemir (2025)** 'in yaptığı araştırmada, İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Servisine 1 Ocak 2022–31 Aralık 2022 tarihleri arasında herhangi bir nedenle başvuran ve adli vaka olarak kayıtlara geçen çocuklar üzerinde gerçekleştirilmiştir.
- Çalışmada adli vakaların büyük bir kısmının önlenebilir nedenlerden kaynaklandığı ve bu vakaların en sık 0–6 yaş grubundaki çocuklarda görüldüğü saptanmıştır.
- Tüm başvurular içinde zehirlenmelerin her yaş grubunda yüksek oranda olduğu, kız çocuklarında intihar girişimlerinin, erkek çocuklarında ise alkol kullanımının ön plana çıktığı belirlenmiştir.
- Cinsiyetin başvuru nedenini etkileyen önemli bir faktör olduğu, ayrıca savaş ve göç gibi etmenlerin adli vaka sayısındaki artışta etkili olduğu tespit edilmiştir

Kırmızıgöl, Taştekin, Özensoy ve Hekimoğlu (2023) tarafından yapılan çalışmada

- *Araştırmanın evrenini acil serviste çalışan 190 hemşire oluşturmuş, eğitimin tamamına katılan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 127 hemşire örneklem olarak alınmıştır.*
- *Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, literatür doğrultusunda hazırlanmıştır.*
- *Çalışma, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütülmüş olup, veriler 2021 yılı Aralık ayında verilen eğitim sonrasında toplanmıştır.*
- *Eğitim öncesinde katılımcılara ön test uygulanmış, ardından adli tıp uzmanı tarafından bir saatlik eğitim verilmiştir.*
- *Eğitim öncesinde katılımcıların %36,2'si, eğitim sonrasında ise %69,3'ü, bir olgunun adli vaka olarak değerlendirilebilmesi için ekimoz varlığının yeterli olduğunu belirtmiştir.*
- *Eğitim öncesinde katılımcıların %90,6'sı, eğitim sonrasında ise %95,3'ü, adli bir olguda lezyonlarda yabancı cisim veya çamur kontaminasyonu bulunması durumunda, sorumlu hekime haber verilmeden lezyonların temizlenmemesi gerektiğini ifade etmiştir.*
- *Eğitim öncesinde hemşirelerin %76,4'ü, eğitim sonrasında ise %78,7'si, adli bir olguya müdahale sırasında eldiven kullanılması gerektiğini belirtmiştir.*

ACİL BİRİMDE ADLİ OLGUYA YAKLAŞIM

- Acil servisler, suç ve şiddet olaylarında mağdur ya da suçluların en sık başvurduğu ve adli vaka muayene ile tedavisinin ilk yapıldığı birimlerdir (Kırmızıgül, Taştekin, Özensoy & Hekimoğlu, 2023)
- Adli olgularda öncelik hayati fonksiyonların korunmasıdır; ancak aciliyet nedeniyle adli delillerin göz ardı edilme riski bulunmaktadır (Kırmızıgül, Taştekin, Özensoy & Hekimoğlu, 2023)

ADLI DEĞERLENDİRMENİN ÖĞELERİ

01	Öykü alma	05	Kanıtın saklanması
02	Fiziksel muayene	06	Kanıt Koruma Zincirinin Sağlanması
03	Kanıtın tanımlanması	07	Kanıtın Kayıt Edilmesi
04	Kanıtın toplanması	08	Krize Müdahale

ADLİ DEĞERLENDİRMENİN ÖĞELERİ

ÖYKÜ ALMA

01

- Adli vakada, genel hemşirelik öyküsüne ek olarak olayın ne, nerede ve ne zaman olduğu sorgulanıp hastanın şikâyeti dinlenmeli, olayın oluşumu hakkında bilgi alınmalıdır.
- Hastanın sözel ifadeleri değiştirilmemeli, **sorular açık, anlaşılır ve yönlendirici olmayan şekilde** sorulmalıdır.

FİZİKSEL MUAYENE

02

- Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti” hakkında yönetmelik gereğince suça ilişkin iç ve dış beden muayenesi **yasal olarak tabip tarafından** yapılır.
- Adli vaka şüphesi olan hastanın muayene öncesinde **giysilerini değiştirmesi ve banyo yapması engellenmeli** ve muayene öncesinde hastaya anlayabileceği dilde bilgi verilerek **sözel onam** alınmalıdır.
- Fiziksel muayene **mahremiyeti sağlanmış** bir ortamda yapılmalı; istenirse başka bir hemşire muayeneye katılabilir. Hemşirenin yaklaşımı yumuşak ve güven verici olmalıdır.
- Muayene odası yeterli ışık ve gerekli tıbbi malzemelerle donatılmalıdır.

ADLI DEĞERLENDİRMENİN ÖĞELERİ

KANITIN TANIMLANMASI

03

- Hemşirenin küçük detayları fark etmesi ve doğru şekilde kaydetmesi, adli olayın ortaya çıkarılmasında kritik öneme sahiptir.
- Aile içi şiddet mağduru vakalarında hasta- aile arasındaki **ifade tutarsızlıkları, hastanın ses tonu ve vücut dili**, adli vakanın tanımlanmasına ipucu sağlayabilir.
- Hemşirenin erken fark etme ve müdahalesi, hastayı daha ileri düzey psikolojik ve fiziksel zararlardan koruyabilir.

KANITIN TOPLANMASI

04

- Kanıt, “**sanık ya da mağdurun suçun işlenmesi esnasında kullandığı, bıraktığı, uzaklaştırdığı, değiştirdiği ya da kontamine ettiği her şeydir**”.
- **Fiziksel kanıtlar**, kurşun, giysi, saç, iplik, tükürük, meni, ısırma izleridir.
- **Fiziksel olmayan kanıtlar** ise psiko-sosyal öykü alma sırasında, intihar girişimi, şiddet, suistimal, kendine zarar verme gibi travma eğiliminin değerlendirilmesidir.

(Özden ve Yıldırım, 2009)

ADLİ DEĞERLENDİRMENİN ÖĞELERİ

KANITIN TOPLANMASI - DEVAM

04

- Adli vaka olarak tanımlanmayan durumlarda bile **hastanın giysileri** önemli bir adli kanıttır.
- Giysiler üzerinde **kan, seminal sıvı, saç, lif, toprak, bitki kalıntıları, barut artıkları, cam parçaları veya parmak izi** bulunabilir.
- Hastadan giysilerini **yere serilmiş beyaz veya kahverengi kâğıt** üzerinde çıkarması istenmelidir.
- **Giysilerin ayakta durarak çıkarılması**, düşebilecek kıl ve liflerin korunması açısından önemlidir.
- Hasta giysilerini çıkarırken odadan çıkılmamalıdır (kanıt kaybını önlemek için).
- Çıkarılan **giysiler kesinlikle silklenmemelidir.**
- Giysiler mümkünse **katlanmamalıdır**; katlanması gerekiyorsa üst üste gelen bölümlerin arasına kâğıt yerleştirilmelidir.
- Hasta ayakkabılarını da çıkarmalıdır, çünkü ayakkabılar önemli adli ipuçları içerebilir.

ADLİ DEĞERLENDİRMENİN ÖĞELERİ

KANITIN SAKLANMASI

05

- Giysi ve eşyalar polis memuru dışında kimseye teslim edilmemelidir. Kanıtlar, teslim edilene kadar **kilitli, camlı ve raflı bir dolapta** güvenli şekilde saklanmalıdır.
- Aile üyelerinin, hastanın giysilerini almasına izin verilmemelidir.(Fail aileden veya yakın çevreden biri olabilir)
- Hastane personeli, polis izni olmadan giysilerin yıkanmak üzere eve gönderilmemesi konusunda bilgilendirilmelidir.

KANIT KORUMA ZİNCİRİNİN SAĞLANMASI

06

- Hemşire kanıt zincirinin doğru olarak sağlanması için gözlem yapmakta ya da örnekleri almada ve kanıtların uygun koşullarda paketlenmesinde görev almaktadır.
- Kanıt koruma zincirindeki herhangi bir kişi mahkemeye şahit olarak çağrılabilir.

ADLI DEĞERLENDİRMENİN ÖĞELERİ

KANIT KORUMA ZİNCİRİNİN SAĞLANMASI

06

- Her bir kanıt **ayrı ayrı** kağıt paket/zarf içine yerleştirilmelidir,
- Kanıtın yer aldığı paket/zarf bant ile kapatılmalı ve mühürlenmelidir,
- Paket/zarfa **bireyin adı, bireyin protokol numarası, doğum tarihi, örneğin ne olduğu, nereden ve ne zaman alındığı** yazılmalıdır,
- **Kanıtları toplayanın adı, unvanı, hastanenin adı ve kliniği** yazılmalıdır,
- Her kanıt tek tek kayıt edilmeli ve kanıtı toplayan personel pakete ve her bir paket/zarfa gün ve tarih belirterek imza atmalıdır. Eğer zaman açıklanamaz ise, kanıtın uygun olmadığı düşünülecektir,
- Her kim kanıtı alırsa adını, pozisyonunu deftere yazması istenmelidir. Polis memuru ya da diğer alıcıda ofisindeki kayıt defterini doldurmalıdır,
- Kanıt zinciri mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır.

ADLİ DEĞERLENDİRMENİN ÖĞELERİ

KANITIN KAYIT EDİLMESİ

07

- Bazı vakalar başlangıçta adli olgu olarak tanımlanmadan acil servise veya kliniğe kabul edilebilir.
- Bu nedenle hemşirelerin ayrıntılı veri toplaması ve doğru kayıt tutması, adli olayın aydınlatılmasında kritik öneme sahiptir.
- Yapılan bir çalışmada, hemşire ifadeleri ile adli rapor bilgilerinin çoğunlukla uyuşmadığı belirlenmiştir.
- Bu uyumsuzluğun;
adli hemşirelik bilgi eksikliği,
standart protokollerin bulunmaması,
ekip anlayışıyla çalışılmaması ve
yasal düzenlemeler hakkında yeterli bilgi sahibi olunmaması
nedenlerinden kaynaklandığı ifade edilmiştir.

ADLI DEĞERLENDİRMENİN ÖĞELERİ

KRİZE MÜDAHALE

08

- Adli vakayı değerlendirme süreci, hemşirenin kendi algı ve değerlerinden etkilenebilir; bu nedenle **hemşire duygularının farkında olmalı, kontrol etmeli ve objektif davranmalıdır.**
- Hemşire, kişisel duygularını uygulamalarına **yansıtmamalıdır.**
- Adli vakalarda hemşire–hasta iletişimi, hasta ile ilk karşılaşma anında başlamalıdır.
- İletişimin ilk aşamasında hemşire, hasta ile güven verici ve saygılı bir iletişim kurmalıdır.

ADLİ DEĞERLENDİRMENİN ÖĞELERİ

KRİZE MÜDAHALE

08

- Tüm işlemler sırasında hastaya kısa, açık ve açıklayıcı bilgiler verilmelidir.
- Adli vakayı dikkatli ve empatik dinlemek büyük önem taşır.
- **Hemşire, hastanın ruhsal durumunu değerlendirmeli;** korku, davranış bozuklukları, regresyon, düşük benlik saygısı, depresyon, intihar girişimi ile alkol ve madde kullanımını gözlemlemelidir.
- Gerektiğinde psikolojik destek sağlanması için sağlık ekibiyle iş birliği yapılmalıdır.

(Özden ve Yıldırım, 2009)

- **Akçin ve Yılmaz Güven (2024)** tarafından yapılan çalışmanın evrenini, 30 Mart–30 Mayıs 2023 tarihleri arasında Karabük İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı eğitim ve araştırma hastanesi ile devlet hastanelerinin acil servislerinde görev yapan 81 sağlık profesyoneli (hemşire, ebe, acil tıp teknisyeni ve sağlık memuru) oluşturmuştur.
- Çalışmada katılımcıların %63,4’ü adli vakalar hakkında bilgi sahibi olmadığını, %95,1’i adli vaka yönetimine ilişkin hizmet içi eğitim almadığını, %31,7’si adli vaka sürecinin işleyişini bilmediğini ve %74,4’ü adli vaka yönetimi konusunda kendisini yeterli hissetmediğini ifade etmiştir. Buna karşın, katılımcıların %73,2’si adli süreçte evrak teslimine ilişkin uyulması gereken prosedürleri bildiğini belirtmiştir.
- Ayrıca çalışmada, sağlık profesyonellerinin adli kanıtların toplanması ve saklanması konusunda yetersiz oldukları saptanmıştır (Akçin & Yılmaz Güven, 2024).

VAKA ÖRNEKLERİ

VAKA 1

- Üç çocuklu bir ailenin 3 yaşındaki orta çocuğu, düşme sonrası travma şikâyetiyle babası tarafından hastanenin **acil servisine getirildi**.

İlk başvuruda yapılan fizik muayenede kulak kanaması dışında patolojik bulgu saptanmadı; hayati bulgular stabildi.Çocuk, baş travması şüphesiyle 24 saatlik medikal gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

- Bir hafta sonra, konuşma sırasında fark edilen yüz asimetrisi şikâyetiyle **tekrar hastaneye getirildi**.

Fizik muayenede sol kulak zarının üst kısmında hematoma tespit edildi.

Yapılan bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT), sol temporal kemikte doğrusal kırık ve orta kulakta hematoma saptandı.Çocuğa sol periferik yüz felci tanısı konularak tedavi başlandı ve tedavi sonrası taburcu edildi.

VAKA 1- DEVAMI

Dört ay sonra, çocuk 3–4 metre yüksekliğindeki balkondan düştüğü iddiasıyla **yeniden hastaneye getirildi.**

Bu başvuruda **fizik muayenede;**

- Sol periorbital ödem ve ekimoz,
- Sol temporal bölge ve yanakta yüzeysel kesi ve deformasyon,
- Sağ ön kolda palpasyonla ağrı ve deformasyon saptandı.
- Sağ ön kol grafisinde, ön kol kemiklerinde spiral kırıklar tespit edildi.

Yaralar acil serviste temizlendi ve sağ ön kol alçıya alındı.

Değerlendirmeyi yapan hekim, çocuk istismarı şüphesiyle hastaneye yatış önerdi.

Baba yatış önerisini kabul etmedi ve çocuğu hastaneden alarak evine götürdü.

Bunun üzerine hekim tarafından adli rapor düzenlenerek hastane polisine bildirildi.

Yapılan incelemede, babanın işsiz ve alkol bağımlısı olduğu belirlendi.

Baba hakkında çocuk istismarı suçlamasıyla adli süreç başlatıldı.

VAKA 2

- İki çocuklu bir aileden **2,5 yaşındaki erkek çocuk**, **üvey annesi tarafından bilinç kaybı** şikâyetiyle hastane aciline getirildi.
- **Fizik muayenede spontan solunum ve nabız olmadığı**, pupillerin **sabit ve dilate** olduğu, **ışık refleksinin alınamadığı** saptandı. Hasta **entübe edilerek kardiyopulmoner resüsitasyona (KPR)** alındı. **30 dakikalık resüsitasyona yanıt alınamadı** ve eksitus kabul edildi.
- Ölüm nedeninin **şüpheli** olması nedeniyle, hekim tarafından **adli rapor düzenlenerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi**.

- **Vaka sonucu olarak**

Çocuğun nefes alırken **hırıltı çıkarmaya başlaması** üzerine annenin panikleyerek çocuğu hastaneye götürdüğü belirlendi. Anne, **ağır ihmal sonucu kasten adam öldürme** suçundan **tutuklandı fakat dokuz ay sonra serbest bırakıldı**. Hayatta kalan **diğer kardeşin çocuk bakım kuruluşuna (yetimhane)** yerleştirildiği bildirildi.

VAKA 2 - DEVAMI

- Ertesi gün yapılan **otopside**;

Boyun, göğüs, sırt ve alt ekstremitelerde **0,5–1 cm çaplarında eski ve yeni ekimozlar**,

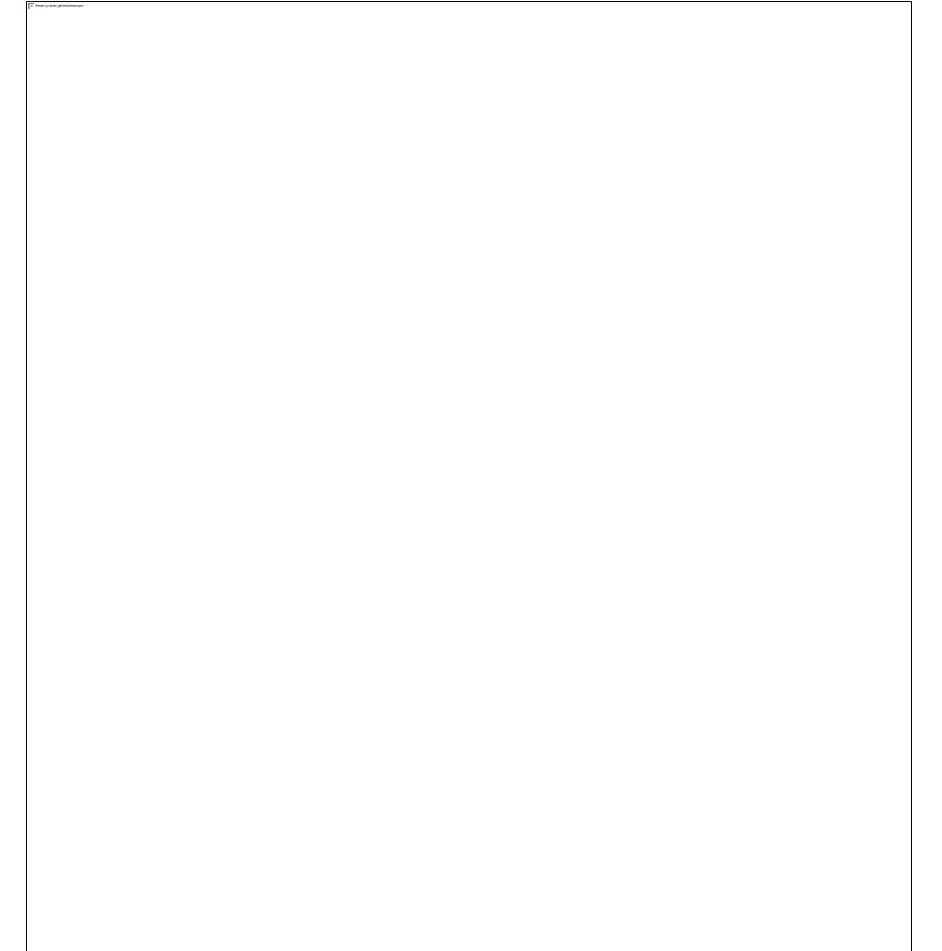
Sağ göz kapağında **1 cm çapında kırmızı-mor ekimoz**,

Sağ alında **0,5 cm çapında kırmızı-mor ekimoz**,

Sol omuz arkasında **kabuk bağlamış, yaklaşık 6 cm uzunluğunda eski yara** saptandı.

Oksipital bölge ve tepe bölgesindeki saçlı deride **eski ve yeni (kırmızı) ekimozlar**,

Oksipital kemikte doğrusal kırık tespit edildi.



VAKA 2 - DEVAMI

- **Hukuki soruşturma sonucunda;**

Annenin ikinci evliliğini yaptığı,
İstismara uğrayan çocuğun babanın **ilk evliliğinden** olduğu,
Evliliğin yaklaşık **bir yıllık** olduğu,
Babanın **uzun yol şoförü** olması nedeniyle çoğunlukla şehir dışında çalıştığı belirlendi.

- **Soruşturma kapsamında annenin;**

Çocuğu iterek yere düşürdüğü ve başını zemine çarptırdığı,
Ardından ayaklarıyla tekmelediği,
Bayılana kadar üzerini örtüp su dökerek uyandırmaya çalıştığı,
Daha sonra banyoya götürerek omuzlarından sarsıp hortumla su döktüğü,
Olay sürecinde çocuğun başını bir duvara vurduğu ortaya kondu.

VAKA 3

- Üç çocuklu bir aileden **4 yaşında kız çocuğu**, yabancı cisim aspirasyonu şüphesiyle hastaneye getirilmiş. Çocuğun hastaneye **üvey annesi tarafından** getirildiği öğrenildi. Yapılan ilk değerlendirmede, çocuğun **solunum güçlüğü** olduğu ve solunum yolunda **yabancı cisim** bulunduğu saptandı. Acil müdahale ile yabancı cisim çıkarıldı.
- **Fizik muayenede**, çocuğun vücudunda **çok sayıda eski ve yeni travmatik lezyon** ile **eski yanık izleri** tespit edildi. Antropometrik değerlendirmede, çocuğun boy ve kilosunun **yaşına göre 5.–10. persentil arasında** olduğu belirlendi.
- Muayene süresince çocuğun sorgulamalara **sessiz kaldığı**, buna karşın üvey annenin **öfke hâlinde olduğu** gözlemlendi. Anne, çocuğun dikkatsiz, hiperaktif ve itaatsiz olduğunu; sık sık düştüğünü ve kendisiyle kavga ettiğini ifade etti.

VAKA 3- DEVAMI

- Klinik bulguların çocuk istismarı açısından şüpheli bulunması üzerine anne ayrıntılı sorguya alındı. **Yapılan değerlendirmede**, annenin eşinin ilk evliliğinden olan bu çocuğa **fiziksel şiddet uyguladığını kabul ettiği**, ancak bunu inkâr etmeye çalıştığı öğrenildi. Ayrıca annenin, kendi geçmişinde de istismar öyküsü olduğu belirlendi.
- Hukuki süreç sonucunda çocuk **koruma altına alınarak yetimhaneye yerleştirildi**, anne ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olaydan yaklaşık **4 ay sonra**, kolluk kuvvetleri çocuğun ailesinin onu özlediğini ve tatil amacıyla yanlarına almak istediklerini bildirdi. Bu talep üzerine çocuk **devlet kararıyla ailesine teslim edildi**.
- Aile, daha sonra **velayet talebinde bulundu** ve bu talep kabul edildi. Çocuk ailesiyle yaşamaya devam etti. Ancak **yaklaşık 4 ay sonra**, çocuk **beyin travması nedeniyle hastaneye kaldırıldı** ve yapılan tüm müdahalelere rağmen **hayatını kaybetti**.

VAKA 4

- On iki ve on üç yaşlarında iki kız kardeşin yaşadığı evden gelen sürekli gürültü nedeniyle komşuların dikkatinin çekmesi ve 13 yaşındaki çocuğun komşunun kızına babalarıyla cinsel ilişki yaşadıklarını ifade etmesi üzerine durum emniyet birimlerine bildirilmiştir. Bildirim sonrası her iki çocuk, **fiziksel ve cinsel istismar şüphesiyle** hastaneye yönlendirilmiştir.
- Yapılan ilk değerlendirmede, çocukların annelerinin evi terk ettiği, kız kardeşlerin babalarıyla birlikte yaşadığı ve babanın geçimini düşünlerde müzisyenlik yaparak sağladığı öğrenilmiştir. On üç yaşındaki çocukla yapılan görüşmede, **annelerinin kendilerine sık sık fiziksel şiddet uyguladığı, babalarının ise onları koruduğu, babasıyla ilişkisini “çok iyi”** olarak tanımladığı ve babasını çok sevdiği ifade edilmiştir.
- Görüşme sırasında çocuğun, babasının durumu hakkında yoğun kaygı taşıdığı; **“Babam nerede?”, “Yemek yedi mi?”, “Hasta mı?”, “Onu hapse atmayacaklar değil mi?”** şeklinde tekrarlayıcı sorular sorduğu gözlenmiştir. Bu durum, çocuğun babaya karşı **aşırı ve patolojik düzeyde bağlanma** gösterdiğini düşündürmüştür.

VAKA 4- DEVAMI

- Yapılan fizik muayenede, **fiziksel istismarı düşündürecek herhangi bir travmatik bulguya rastlanmamıştır.** Bununla birlikte, yürütülen adli soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, babanın her iki kızına yönelik **ensest niteliğinde cinsel istismarda bulunduğu** belirlenmiştir. İstismarın başlangıçta öpme ve genital bölgelere dokunma şeklinde olduğu, zamanla babanın genital organını çocuklara gösterdiği, çocuklardan dokunmalarını istediği ve cinsel birleşme girişimlerinde bulunduğu saptanmıştır.
- Psikososyal değerlendirmede, çocuğun yaşadığı durumu **cinsel istismar olarak algılamadığı**, bunu babasıyla kurduğu bir sevgi ve yakınlık ilişkisi olarak yorumladığı anlaşılmıştır. Annenin yokluğunda, çocuğun baba ile kurduğu bu ilişkinin anne sevgisinin yerini doldurmaya yönelik olduğu; babanın sevgisini kaybetmemek amacıyla yaşananları gizlemeye ve babayı korumaya çalıştığı değerlendirilmiştir.

VAKA 4- DEVAMI

- Olayın açığa çıkışı, iki kız kardeşin komşularının çocuklarıyla erkek arkadaşlar hakkında sohbet etmeleri sırasında, kendi deneyimlerini paylaşımlarıyla gerçekleşmiştir. Komşu çocuklarının bu durumun normal olmadığı yönündeki ifadeleri sonrasında, çocukların yaşadıklarının **istismar olduğunun ilk kez farkına vardıkları** belirlenmiştir.
- Adli süreçte, baba, çocukların ve tanıkların ifadelerinin alınması ve adli tıbbi değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından **tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir**. Her iki çocuk ise korunma altına alınarak **çocuk bakım ve sosyal hizmet kurumuna yerleştirilmiştir**.

ADLI VAKALARDA HEMŞİRELİK BAKIMI

ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI OLGU YÖNETİM ALGORİTMASI



- Hemşirelik bakımı istismarın önlenmesiyle başlar, istismar vakalarının tanılanması ve çocuğun ileride tekrar istismar edilmesini önlemeyi kapsar.
- İstismarın ortaya çıkmasında rol oynayan risk faktörleri açısından ebeveyn, çocuk ve çevre özelliklerinin değerlendirilmesine prenatal dönemde başlanır.
- Hemşire ebeveynlerin gebeliğe ilişkin tutumlarını, çocuktan beklentilerini, ebeveynlerin destek sistemlerini inceleyerek risk faktörlerini belirleyebilirler (Geçkil, 2017).

- Profesyonel bir meslek üyesi olarak hemşireler; acil ve adli olaylarda vakayla ilk karşılaşan, hasta ve yakınlarıyla iletişime geçen, muayene sürecinde ve sonrasında eşyalarla temas eden, laboratuvar örneklerini alan sağlık çalışanlarıdır. Bu nedenle adli vakalarda önemli bir sorumluluk ve role sahiptirler (Küçük, 2018, s. 195).
- Hemşirelerin, kanıtları tanımlama, toplama ve saklama ile ilgili prosedür ve teknikleri bilmeleri; tedavi ve bakım sürecinde kanıtların korunması, kaydedilmesi ve adli sürecin sağlıklı yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Acil servise başvuran mağdur ya da faillerde görülen yaralanma veya ölüm vakalarında hemşirelerin kabul sürecinde aktif rol almaları ve sorumluluk üstlenmeleri gerekmektedir (Küçük, 2018, s. 195).

Ülkemizde 2011 yılında **Resmî Gazete’de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği’nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları hemşirelerinin görevleri** arasında çocuk ihmal ve istismarını tanıma, şüpheli durumlarda ilgili kurumlara bildirimde bulunma, ihmal ve istismardan korunma, tanılama, eğitim ve danışmanlık rollerinin yer aldığı belirtilmiştir.

Acil kliniklerde görev yapan hemşireler; çocuk istismarından kazaya bağlı ya da kaza dışı yaralanmalara, zehirlenmelere, intihar girişimlerine, ağır ve ölümcül travmalara kadar çok çeşitli adli nitelikli vakalarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle hemşirelerin adli vakalarda acil tanılama, değerlendirme, müdahale, kanıtların korunması ve yasal bildirim süreçleri konusunda yetkin olmaları gerekmektedir (Küçük, 2018, s. 195).

Tablo 1. İstismarı Önleme

Hemşirelik Bakım Amaçları	Hemşirelik Bakımı Uygulamaları
İstismarı Önleme	• İstismar riski bulunan aileleri tanımak • Anne–bebek bağlanmasını güçlendirmek (dokunma, bakım verme, ziyaret ve konuşmayı teşvik etmek) • Çocuk yetiştirme ve disiplin uygulamaları konusunda eğitim vermek • Çocukların gelişim dönemlerine uygun beklentiler konusunda ebeveynleri bilgilendirmek • Ebeveynlerin yeterlilik duygusu ve benlik saygısını desteklemek • Ebeveynlerin kendini güvende hissetme düzeyini değerlendirmek • Sosyal destek sistemlerini ve ruhsal sorunları değerlendirmek • Destek sistemlerini harekete geçirmek ve ulaşılabilir olmak • 12 yaş üzeri çocukların evde yalnız bırakılmasına yönelik önlemleri öğretmek

Tablo 2. Hastaneye Yatma Sırasında Güvenli Bir Ortam Sağlama

Hemşirelik Bakım Amaçları	Hemşirelik Bakımı Uygulamaları
Hastaneye Yatma Sırasında Güvenli Bir Ortam Sağlama	• Primer Hemşirelik Modeli ile bakım vericilerin sürekliliğini sağlamak • Çocuğun uygun olmayan davranışlarını onaylamaksızın kabul edici ilgi göstermek • Uygun aktiviteler planlamak • Çocuğun benlik saygısını geliştirmek için olumlu özelliklerini övmek

Tablo 3. Şüpheli İstismar Vakalarını Tanıma

Hemşirelik Bakım Amaçları	Hemşirelik Bakımı Uygulamaları
Şüpheli İstismar Vakalarını Tanıma	• Toplum taramaları ile riskli bireyleri belirlemek • Çocuk İstismarını Tarama Ölçeği, Aile İçi Çocuk İstismarı Ölçeği, Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeğini kullanmak • Öykü ve fizik muayenede istismar belirtilerini değerlendirmek • Çocuğun davranışsal ve duygusal durumunu değerlendirmek • Lezyonları kayıt altına almak ve raporlamak • Tanısal işlemlerde çocuğa yardımcı olmak • Şüpheli durumları ekip ile paylaşmak ve ilgili kurumlara bildirimde bulunmak (Kolluk kuvvetleri / Cumhuriyet Savcılığı)

Tablo 4. Hastanedeki Süre İçinde Ebeveynlerin Yeterlilik Duygusunu Artırma

Hemşirelik Bakım Amaçları	Hemşirelik Bakımı Uygulamaları
Ebeveynlerin Yeterlilik Duygusunu Artırma	• Ebeveynlerin klinik ve hastane kurallarına uyumunu sağlamak • Çocuğun bakım ve iyileşme sürecine aktif katılımını desteklemek • Çocuk bakımına yönelik bilgi ve becerileri geliştirmek • İstismarcı davranışı kişisel özellik değil, tedavi edilmesi gereken bir sorun olarak ele almak • Krizli durumları tanıma ve baş etme konusunda rehberlik etmek • Sosyal desteklerin fark edilmesini ve kullanılmasını sağlamak • Ebeveyn destek gruplarına katılımı teşvik etmek

Tablo 5. İstismarın Tekrarını Önleme

Hemşirelik Bakım Amaçları	Hemşirelik Bakımı Uygulamaları
İstismarın Tekrarını Önleme	• Eve veya bakım kurumuna dönen çocuğun düzenli izlenmesi için multidisipliner çalışma yürütmek • Halk sağlığı veya okul hemşiresi tarafından ihmal ve istismar belirtilerini izlemek • Ebeveynlerin istismarı tetikleyen durumları tanımasına ve önlem almasına yardımcı olmak • Maddi, barınma ve iş desteğine ihtiyacı olan aileleri sosyal yardım kuruluşlarına yönlendirmek

Tablo. Çocuğun Anksiyetesini Azaltmaya Yönelik Hemşirelik Bakımı

Hemşirelik Bakım Amaçları	Hemşirelik Bakımı Uygulamaları
Çocuğun Anksiyetesini Azaltma	• Çocuğa "istismar kurbanı" gibi değil, diğer hastalar gibi yaklaşmak • Aynı soruları tekrar tekrar sormaktan kaçınmak • Duygularını ifade etmesini sağlamak amacıyla ev ve aile temalı oyunlar planlamak • Çocuk–ebeveyn ilişkisinin sağlıklı gelişmesini desteklemek • Çocuğu ebeveynleri hakkında olumlu duygularını ifade etmeye teşvik etmek • Ebeveynlerin davranışlarını çocuk önünde eleştirmekten kaçınmak • Çocuk krizle baş etmede regresyon kullanıyorsa anlayışla karşılamak

EK 1: Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği'nin Türkçesi-2.0 (Çeviren: © Vedat Şar).

Bu sorular **çocukluğunuzda ve ilk gençliğinizde (20 yaşından önce)** başınıza gelmiş olabilecek bazı olaylar hakkındadır. Her bir soru için sizin durumuza uyan rakamı daire içersine alarak işaretleyiniz. Sorulardan bazıları özel yaşamınızla ilgilidir; lütfen elinizden geldiğince gerçeğe uygun yanıt veriniz. Yanıtlarınız gizli tutulacaktır.

1. Hiç Bir Zaman 2. Nadiren 3. Kimi zaman 4. Sık olarak 5. Çok sık

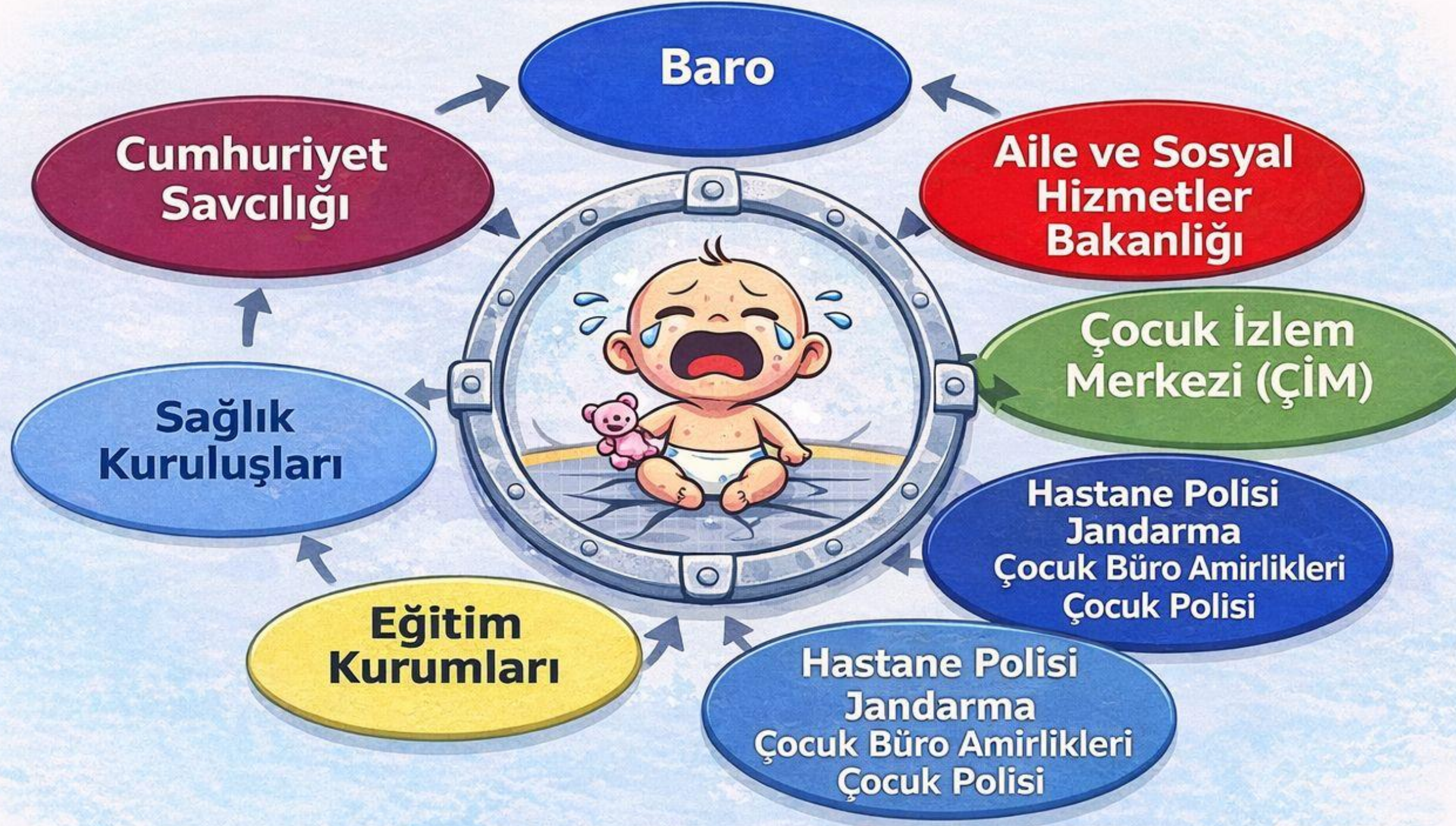
Çocukluğumda ya da ilk gençliğimde...

1. Evde yeterli yemek olmadığından aç kalırdım.
2. Benim bakımımı ve güvenliğimi üstlenen birinin olduğunu biliyordum.
3. Ailemdelikler bana "salak", "beceriksiz" ya da "tipsiz" gibi sıfatlarla seslenirlerdi.
4. Anne ve babam ailelerine bakamayacak kadar sıklıkla sarhoş olur ya da uyuşturucu alırlardı.
5. Ailemde önemli ve özel biri olduğum duygusunu hissetmeme yardımcı olan biri vardı.
6. Yırtık, sökükle ya da kirli giysiler içersinde dolaşmak zorunda kalırdım.
7. Sevişdiğimi hissediyordum.
8. Anne ve babamın benim doğmuş olmamı istemediklerini düşünüyordum.
9. Ailemden birisi bana öyle kötü vurmuştu ki doktora ya da hastaneye gitmem gerekmişti.
10. Ailemde başka türlü olmasını istediğim bir şey yoktu.
11. Ailemdelikler bana o kadar şiddetle vuruyorlardı ki vücudumda morartı ya da sıynıklar oluyordu.
12. Kayış, sopa, kordon ya da başka sert bir cisimle vurularak cezalandırılıyordum.
13. Ailemdelikler birbirlerine ilgi gösterirlerdi.
14. Ailemdelikler bana kırıcı ya da saldırganca sözler söylerlerdi.
15. Vücutça kötüye kullanılmış olduğuma (dövölme, itilip kakılma vb.) inanıyorum.
16. Çocukluğum mükemmeldi.
17. Bana o kadar kötü vuruluyor ya da dövölüyordum ki öğretmen, komşu ya da bir doktorun bunu farketdiği oluyordu.
18. Ailemde birisi benden nefret ederdi.
19. Ailemdelikler kendilerini birbirlerine yakın hissederlerdi.
20. Birisi bana cinsel amaçla dokundu ya da kendisine dokunmamı istedi.
21. Kendisi ile cinsel temas kurmadığım takdirde beni yaralamakla ya da benim hakkımda yalanlar söylemekle tehdit eden birisi vardı.
22. Benim ailem dünyanın en iyisiydi.
23. Birisi beni cinsel şeyler yapmaya ya da cinsel şeylere bakmaya zorladı.
24. Birisi bana cinsel tacizde bulundu.
25. Duygusal bakımdan kötüye kullanılmış olduğuma (hakaret, aşağıılama vb.) inanıyorum.
26. İhtiyacım olduğunda beni doktora götürecek birisi vardı.
27. Cinsel bakımdan kötüye kullanılmış olduğuma inanıyorum.
28. Ailem benim için bir güç ve destek kaynağı idi.

- Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ), Bernstein ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir.
- Ölçek, 3'ü travmayı minimize etmeyi ölçen olmak üzere toplam 28 maddeden oluşmaktadır.
- Beş alt boyutu bulunmaktadır:
- Cinsel istismar
- Fiziksel istismar
- Duygusal (emosyonel) istismar
- Fiziksel ihmal
- Duygusal (emosyonel) ihmal
- Alt boyut puanlarının birleşimiyle toplam travma puanı elde edilmektedir.

Şar, V., Öztürk, E., & İkikardeş, E. (2012). Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği'nin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. *Türkiye Klinikleri Tıp89 Bilimleri Dergisi*, 32(4), 1054–1063.

İstismar Olayını Bildirebileceğiniz Birimler



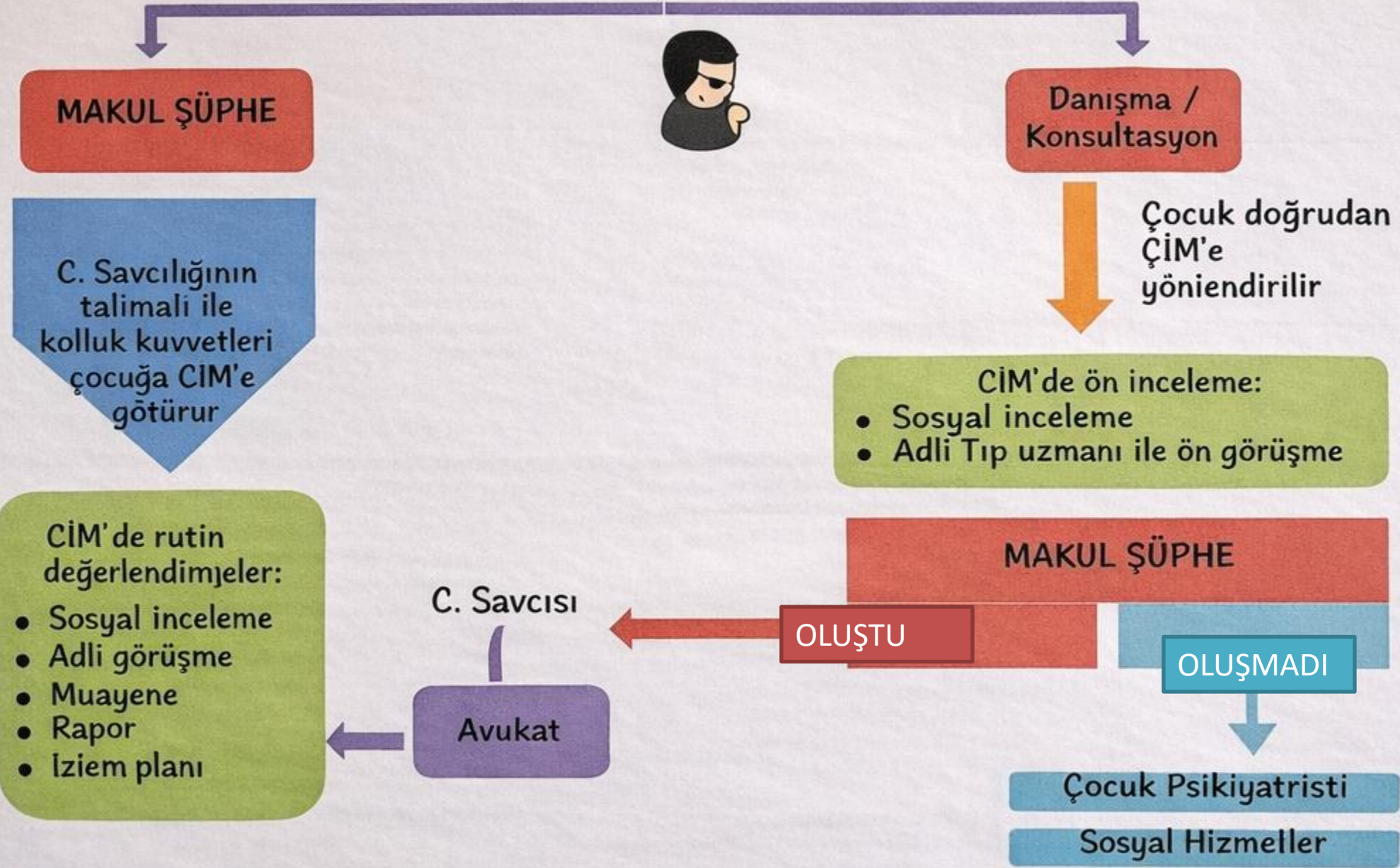
ÇOCUK İZLEM MERKEZİ (ÇİM)

- Cinsel istismar şüphesi olan çocuğun beyanının alınması, muayenesinin yapılması, aile görüşmesinin yapılması ve raporunun hazırlanması için gereken tüm personel ve ekipmanın bulunduğu, işlemlerin her aşamada çocuğun yüksek yararı gözetilerek yürütüldüğü bir merkezlerdir.
- Cinsel istismara uğradığı bilinen, cinsel istismar kuşkusu olan ya da bu amaçla danışılması düşünülen çocuklara hizmet etmektedir.
- Bu merkezde çocukla ve ailesi ile görüşülmekte ve olayla ilgili bilgiler alınmaktadır.Çocuğun fizik muayenesi, ilk ruhsal değerlendirmesi ve adli tıp değerlendirmesi de burada uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.

AİLE VE SOSYAL ÇALIŞMA BAKANLIĞI SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ

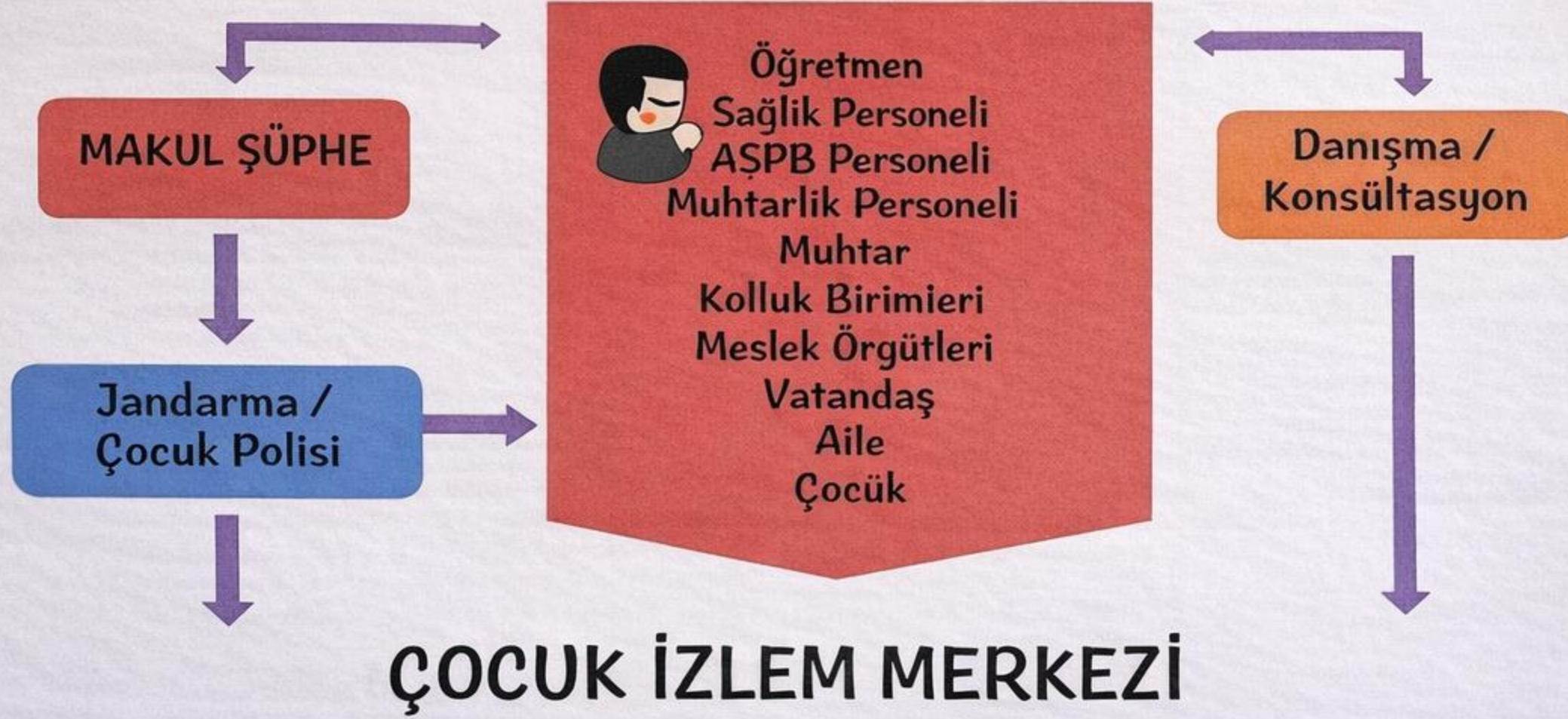
- Hastane Sosyal Hizmet Birimleri
- İl/İlçe Sosyal Hizmet Müdürlükleri
- Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM)
- 112
- 183

ÇOCUK İZLEM MERKEZİNİN İŞLEYİŞ SÜRECİ



4. ÇİM'in İşleyişı

Cinsel istismar düşünölen çocuęun ÇİM'e ulaşımı





Çocuk Koruma Birimi



Çalışma Alanları	Çalışanlar	Gerekli Odalar	Başvuru	Başvuru
 Cinsel İstismara	 Psikolog	 Bekleme odası	 1. Bekleme odası	 C. Savcısı/ Mahkeme
 Fiziksel İstismara	 Hemşire	 (Psikolog/SHU) Uzman odası	 2. (Psikolog/SHU) Uzman odası	 Kendi başvurusu
 İhmale uğramış/ iddiası ile gelen çocuklar	 Adli Tıp Uzmanı	 (Psikolog/SHU) Uzman odası	 3. Aynalı oda (Ön/Arka)	 Hastane yönlendirme
 Vasi Tayini	 Sosyal Hizmet Uzmanı	 Çocuk Cerrahı	 4. Hemşire odası	 Diğer sağlık birimleri yönlendirme
 SSÇ / Ceza Sorumluluğu Tespiti	 Çocuk Cerrahı	 Çocuk Hastalıkları Uzmanı	 5. Hemşire odası	 AÇSB yönlendirme
 Kronolojik Yaş Tahmini (Kemik Yaşı)	 Sekreter	 İlgili uzmanlar	 6. Doktor odası	 MEB yönlendirme
 Babalık Tayini	 İlgili uzmanlar		 7. Toplantı odası	



**Erkek kardeşim dün gece
uyumama izin vermedi**

**Komşumuz “X “abi çok
komik iç çamaşırlar
giyiniyor**

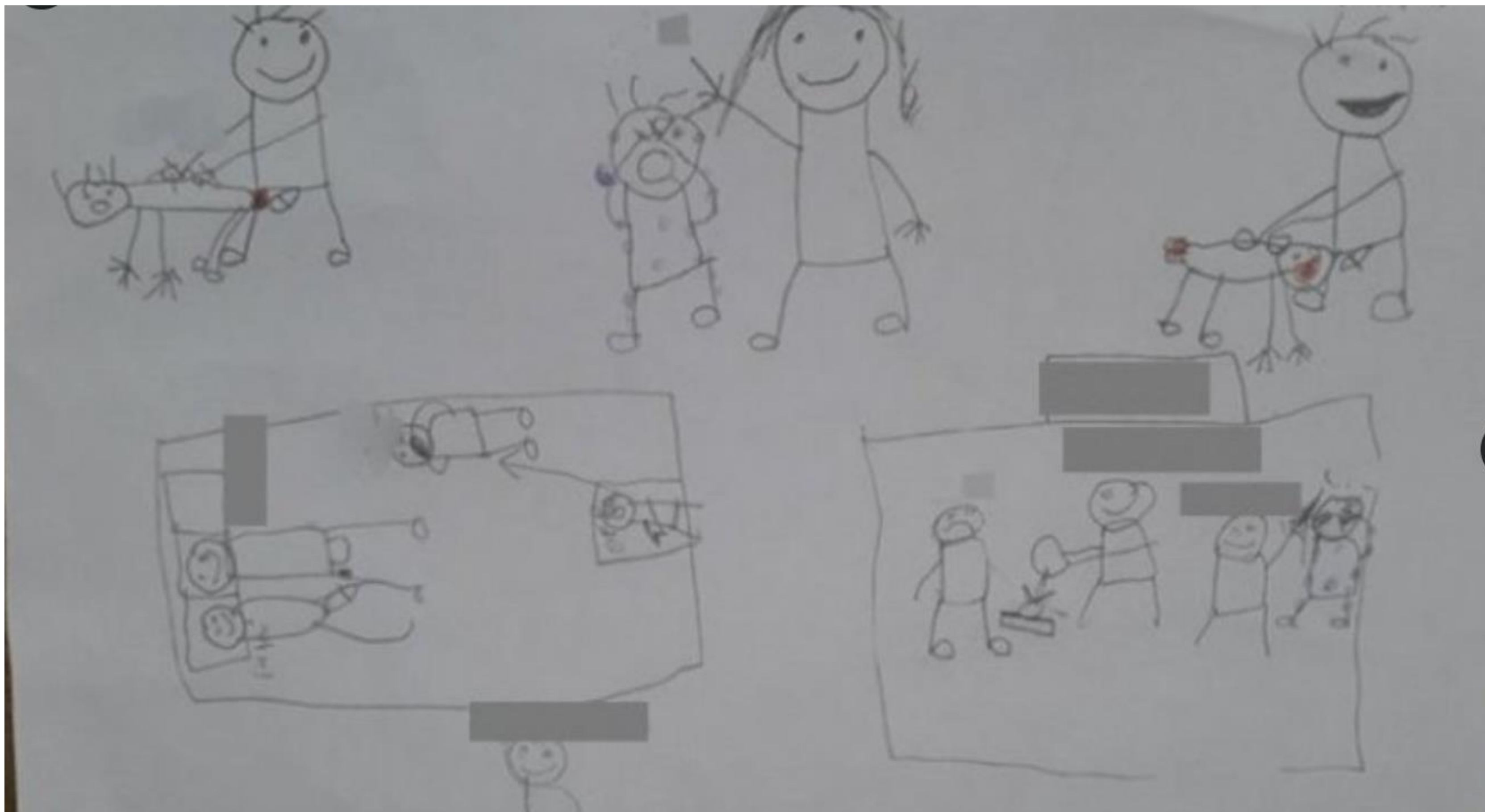
**Annemin beni amcamla
yalnız bırakmasından hiç
hoşlanmıyorum**

**Çok kötü
biçimde
ellenilen bir kız
tanıyorum**

**Tanıdığım bir kız var,
annesine rahatsız
edildiğini söyledi fakat
annesi ona inanmadı**

**Komşumuzun
oğlu
beni çok
sıkıştırıyor**

**Gibi dolaylı ifadeler durumunda çocuğu
uzman birine yönlendirin.**





| Tacize uğrayan çocuk yaşadıklarının resmini çizdi

28.05.2015 - 11:49

Güncellenme Tarihi: 28.05.2015 - 12:20

A+

A-

...



ÇOCUK İSTİSMARININ ÇOĞU GİZLİ KALIR?

Çocuklar gizler
İstismarcılar gizler
Ebeveynler gizler
Tanıklar gizler
Uzmanlar gizler

YA DA

**HİÇ FARKINA
VARMAZLAR**



ÇOCUK SUSAR
SEN SUSMA
İSTİSMARA
SESSİZ KALMA



KAYNAKÇA

- Akçin, A., & Yılmaz Güven, D. (2024). Acil serviste çalışan sağlık profesyonellerinin adli vakalar ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi. MAUN Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 38–48.
- Bozbuğa, Ö., Çalışkan, Z., & Özdemir, F. (2025). Çocuk acile başvuran adli vakaların değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 12(1), 21–28.
- Çolak, B., Karakaya, I., Kurtaş, Ö., Şişmanlar, Ş., & Biçer, Ü. (2009). Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na başvuran çocuklara yönelik cinsel istismar olguları (1998–2006). Adli Tıp Bülteni, 14(2), 71–79.
- Donaldson, A. E. (2022). Forensic professionals' thoughts on New Zealand emergency nurses' forensic science knowledge and practice. International Emergency Nursing, 62, 101151.
<https://doi.org/10.1016/j.ienj.2022.101151>
- Erdemir, F. (2012). Hemşirelik tanıları el kitabı (ss. 67–179). Nobel Tıp Kitabevleri.
- Geçkil, E. (2017). Çocuklarda fiziksel istismar ve hemşirelik yaklaşımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 129–139.
- İlçe, A., Yıldız, D., Baysal, G., Özdoğan, F., & Taş, F. (2010). Acil servislerde çalışan sağlık bakım personelinin adli olgularda delillerin korunması ve saklanmasıyla yönelik bilgi ve uygulamalarının incelenmesi. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi, 16(6), 546–551.

KAYNAKÇA

- İncirkuş, K., Şensoy, B. N., & Gülyeri, E. E. (2025). Çocuk ihmal ve istismarında güncel hemşirelik yaklaşımları. Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(2), 98–103. <https://doi.org/10.33308/2687248X.202572346>
- Karabulutlu, Ö., Aydın, C. M., & Temel, M. Ö. (2023). Acil servis çalışanlarının adli vaka yönetimine yönelik bilgi düzeyleri: Kars örneği. Caucasian Journal of Science, 10(1), 12–24. <https://doi.org/10.48138/cjo.1263567>
- Kırmızıgül, H., Taştekin, B., Özensoy, H. S., & Hekimoğlu, Y. (2023). Acil serviste çalışan hemşirelere verilen adli vakalarda bilgi ve uygulamalarına yönelik eğitimin etkisinin belirlenmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 8(2), 273–280.
- Küçük, S. (2018). Çocuk istismarında acil hemşirelik yaklaşımı. İ. Kahriman, H. Karadeniz, A. Şahin & Ö. Tatlı (Ed.), Çocukluk çağı kazalarında acil yaklaşım içinde (ss. 194–197). Akademisyen Kitabevi.
- Özden, D., & Yıldırım, N. (2009). Adli vakaya hemşirelerin yaklaşımı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 73–81.
- Pelendecioğlu, B., & Bulut, S. (2016). Çocuğa yönelik aile içi fiziksel istismar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 49–62.
- Çolak ve ark., (2009)
- Saka, N. E., Çelik, C., & Ata, U. (2024). Çocuk ihmal ve istismarı: On yıllık hedefin stratejisi “INSPIRE” “check-list” ötesine geçer mi? Ümit “var” mı? Ümitvar “olmak” mı? Adli Tıp Bülteni, 29(3). <https://doi.org/10.17986/blm.1710>

KAYNAKÇA

- Silva, R. X., Ferreira, C. A. A., Sá, G. G. M., Souto, R. Q., Barros, L. M., & Galindo-Neto, N. M. (2022). Preservation of forensic trace by nursing in emergency services: A scoping review. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 30, e3593.
<https://doi.org/10.1590/1518-8345.5849.3593>
- Şar, V., Öztürk, E., & İkikardeş, E. (2012). Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği'nin Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliği. *Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi*, 32(4), 1054–1063.
- T.C. Resmî Gazete. (2011, 19 Nisan). Hemşirelik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik (Sayı: 27910).
<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110419-5.htm> (Erişim tarihi: 12 Şubat 2026)
- UNICEF. (2010). Türkiye’de çocuk istismarı ve aile içi şiddet araştırması: Özet rapor.
<https://www.unicef.org/turkiye/raporlar/t%C3%BCrkiyede-%C3%A7ocuk-istismari-ve-aile-i%C3%A7i-%C5%9Fiddet-ara%C5%9Ftirmasi-%C3%B6zet-raporu-2010> (Erişim tarihi: 12 Şubat 2026)
- UNICEF. (2024). The state of the world’s children 2024: The future of childhood in a changing world.
<https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children/2024> (Erişim tarihi: 12 Şubat 2026)
- World Health Organization. (2024, 5 Kasım). Child maltreatment. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment> (Erişim tarihi: 12 Şubat 2026)
- World Health Organization. INSPIRE: seven strategies for ending violence against children.
<https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/207717/9789241565356-eng.pdf?sequence=1> (Erişim tarihi: 12 Şubat 2026)